NTS N° 239 -2025/MINSA/DGAIN

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE VÍAS DE CUIDADO INTEGRAL EN SALUD

I. FINALIDAD

Contribuir al fortalecimiento de la coordinación del cuidado integral de salud de la persona, la familia y la comunidad, entre los prestadores de salud, los usuarios de los servicios de salud, los financiadores y otros actores relacionados, para brindar el cuidado de forma oportuna, continua e integral.

II. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer el marco normativo para estandarizar el proceso de elaboración e implementación de las vías de cuidado integral en salud, en el marco de las Redes Integradas de Salud y el Modelo de Cuidado Integral de Salud.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Establecer las características, tramos y enfoques de las vías de cuidado integral en salud.

2.2.2 Establecer la metodología y herramientas para la planeación, la formulación, la implementación y la evaluación de las vías de cuidado integral en salud.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

C. ALVARADO CH.

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación obligatoria para el Ministerio de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana, así como para los Establecimientos de Salud y Servicios Médico de Apoyo pertenecientes al Ministerio de Salud, al Seguro Social de Salud, a los Gobiernos Regionales, a los Gobiernos Locales, a las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, al Instituto Nacional Penitenciario – INPE; y otros Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo públicos, privados y mixtos, así como en Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas, privadas y mixtas.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS.
- Decreto Legislativo N° 1504, que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades.
- Decreto Urgencia N° 017-2019-SA, que establece Medidas para la Cobertura Universal de Salud.
- Decreto Supremo N° 023-2021-SA, que aprueba la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 019-2024-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS).
- Decreto Supremo N° 026-2020-SA, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable".
- Decreto Supremo N° 016-2021-SA, que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial 2030 de la Política Nacional Multisectorial de Salud "Perú, País Saludable".
- Decreto Supremo Nº 042-2023-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial.
- Resolución Ministerial Nº 366-2017/MINSA, que aprueba los "Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú".
- Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento técnico: Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI).
- Resolución Ministerial N° 220-2021-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de Implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, Familia y Comunidad (MCI).
- Resolución Ministerial N° 826-2021-MINSA, que aprueba las Normas para elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 327-2022/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 329/MINSA/2022-DGAIN de Conformación de Redes Integradas de Salud – RIS.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Definiciones Operativas

a) **Actor social**[1][2][3][4][5][6][7]**:** Es aquel individuo o colectivo con intereses, condiciones y características particulares que lo identifican como tal, capaz de construir y llevar a cabo en forma individual o conjunta, un proyecto de transformación social para la salud, bienestar y desarrollo de la persona, familia y comunidad del territorio de la RIS.

Un actor social individual es un Agente Comunitario de Salud, un promotor de salud, una partera, un líder comunitario, entre otros, que actúa en el territorio de la RIS. Un actor social colectivo es la asociación de vaso de leche, el comité de madres de familias, el comité local comunal, asociación de diabéticos, la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud (JUS), los representantes de sectores del Poder Ejecutivo, los representantes de los Gobiernos Regionales, los alcaldes provinciales y distritales, los Gestores de la Red Integrada de Salud, entre otros, que actúan en el territorio de la RIS.

C. ALVARADO CH.

[1] Adaptada del Artículo 4.- Glosario de términos y denominaciones del Reglamento de la Ley Nº 29124, que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-SA. *Actor Social. - Persona, grupo u organización que interviene de manera activa en los procesos socio- culturales y de desarrollo de una comunidad, región o país.*

[2] Ciudades para un futuro sostenible Boletín # 16, junio 200 I. Perú.

[3] Touraine, A. (1987). Actores sociales y sistemas políticos en América Latina. OIT: Prealc. Pag.12.

[4] Touraine, Alain 1997 Actores sociales, su participación en el desarrollo local capítulo I.

[5] Touraine, Alain (1984) Los conceptos sobre "actor social", han utilizado como referencia:, "Le retour de l'acteur, essai de sociologie", éd. Fayard, Paris, France. Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977) "L'acteur et le système", éd. Seuil, Paris, France. Los conceptos sobre "actor social", han utilizado como referencia: Alain Touraine (1984), "Le retour de l'acteur, essai de sociologie", éd. Fayard, Paris, France. Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977) "L'acteur et le système", éd. Seuil, Paris, France.

[6] Ministerio de Salud (MINSA) (2020), Manual para la Capacitación de Actores Sociales Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

[7] Fox, Jonathan Fox, Jonathan (1992), The Politics of Food in Mexico. State power and Social Mobilization, Ithaca, Cornell Univ. Press (1992), The Politics of Food in Mexico. State power and Social Mobilization, Ithaca, Cornell Univ. Press

b) **Atención de salud**[8]**:** Provisión de prestaciones de salud individual para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, que incluye cuidados paliativos, así como prestaciones de salud pública, con el fin de promover, mantener y restablecer el estado de salud de la población; bajo las modalidades de oferta fija, oferta móvil y telesalud, según corresponda.

c) **Atención Primaria de Salud**[9]**:** Es la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y comunidad; a un coste aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del desarrollo.

d) **Autocuidado**[10]**:** Son las acciones que las personas toman para sí mismas y sus familias con la finalidad de mantener en buen estado físico y mental, satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales; prevenir la enfermedad o accidentes; cuidar sus dolencias menores y afecciones a largo plazo; y mantener la salud y el bienestar después de una enfermedad aguda o al alta del hospital.

e) **Carga de enfermedad**[11]**:** Es la medida de las pérdidas de salud atribuidas a diferentes enfermedades y lesiones, incluyendo las consecuencias mortales y discapacitantes.

f) **Condición de salud**[12]**:** Estado o situación de salud que presenta una persona en un momento determinado. Puede abarcar estados de enfermedad o bienestar y vitalidad. Las condiciones de salud se manifiestan en diferentes aspectos del funcionamiento físico, mental y/o emocional de una persona.

g) **Conflicto de intereses**[13]**:** Es toda situación en la que los intereses privados del servidor civil colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones. Esto, teniendo en cuenta que cualquier actuación suya debe estar dirigida a asegurar el interés público, y no a favorecer intereses personales o de terceros.

h) **Continuidad de la atención**[14][15]**:** Atributo de la Atención Primaria de Salud (APS) referido a la percepción que tiene el usuario de salud sobre el grado en que una serie de eventos de su cuidado integral de salud están coordinados, y que son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo, y son congruentes con sus necesidades y preferencias en salud.

i) **Coordinación del cuidado integral de la salud**[16][17][18]**:** Atributo de la APS referido a la interacción entre el personal de la salud para concertar que todos los servicios de salud, independientemente del lugar donde se brinden, estén

C. ALVARADO CH.

[8] Literal a) del artículo 3 Definiciones y acrónimos del Reglamento de la Ley N°30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2024.
[9] Numeral 6.1.1 Definiciones operativas del Documento Técnico "Plan Nacional de Implementación de Redes Integradas de Salud", aprobado por Resolución Ministerial N°969-2021/MINSA.
[10] Literal b) del numeral 6.3.1 Componentes de provisión del cuidado del Documento Técnico: Modelo de Cuidado Integral de Salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad (MCI), aprobado por Resolución Ministerial N°030-2020/MINSA
[11] Resolución Ministerial N°100-2010/MINSA que aprueba el Documento Técnico: Carga de Enfermedad en el marco de la implementación de los pilotos de aseguramiento Universal en Salud, 2009, pág. 15.
[12] Adaptado de la definición de Salud de la Organización Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad, Gustavo Alcántara Moreno, Revista Universitaria de Investigación, 2008.
[13] Principios, deberes y prohibiciones éticas en la función pública: Guía para funcionarios y servidores del estado, Presidencia del Consejo de Ministros – Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 2016.
[14] Ajustado del Glosario de términos del Documento "La Renovación de Atención Primaria de Salud en las Américas. N°4. Redes Integradas de Servicios de Salud. Conceptos, opciones de Política y Hoja de Ruta para su implementación en las Américas.
[15] Ajustado del artículo de Antonio Fernández Moyano y Manuel Ollero Baturone, "Percepción de la continuidad asistencial. Conocer para actuar" Revista Española de Salud Pública, , vol.84 N° 4. Madrid. 2010.
[16] Starfield, B. et al. Atención primaria y responsabilidades de Salud Publica en seis países de Europa y América del Norte: Un estudio Piloto. Rev. Esp. Salud Púb. N (1) 2004; v.78:17-26.
[17] La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas, N° 1 Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de Salud. Estrategias para el desarrollo de los equipos de APS, Organización Panamericana de la Salud, página 15 y 33.
[18] Equity LA I. Impacto de las estrategias de integración de la atención en redes de servicios de salud de América Latina- Resultados comparativos 2015/2017. Consorci de Salut i Social de Catalunya.

armonizados en una acción o esfuerzo común. La interacción entre el personal de la salud involucra la transferencia y uso de información clínica, provisión de servicios de salud de manera secuencial y complementaria, en base a las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad.

j) **Cuidado Integral de la salud**[19]**:** El Cuidado Integral de la Salud comprende la atención de salud que se brinda a las personas, familia y comunidad en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que integran la Red Integrada de Salud (RIS), articulándose de manera complementaria entre el primer, segundo y tercer nivel de atención de salud, a través de la oferta de servicios de salud que puede ser: oferta móvil, fija o telesalud, y los cuidados que responden a las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad como sujetos de intervención.
El Cuidado Integral de la Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad, se desarrolla acorde al marco normativo determinado por el MINSA, e incluye las intervenciones intersectoriales, sociales e intergubernamentales sobre los determinantes sociales de la salud.

k) **Cuidados paliativos**[20]**:** Es la atención que se ofrece a pacientes y familias, que sufren alguna enfermedad severa, generalmente crónica, progresiva, incurable e intratable, que limita o acorta la vida, y que se acompaña de una serie de síntomas y signos que requieren tratamiento.

l) **Curso de vida**[21]**:** Comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte.

m) **Determinantes Sociales de la Salud** [22]: Son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, y que impactan en la salud de las personas.

n) **Escenario de cuidado:** Se refiere al lugar, espacio o entorno en el que se brindan cuidados de salud a las personas, familias y comunidades. Los escenarios de cuidado pueden ser: establecimientos de salud, hogar, instituciones educativas, centros laborales, municipios, comunidades, entre otros.

o) **Funciones esenciales de la salud pública** [23]**:** Son las capacidades de las autoridades de salud, en todos los niveles institucionales y junto con la sociedad civil, para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre los factores de riesgo y los determinantes sociales que tienen un efecto en la salud de la población.

p) **Gestión clínica:** Denominada también microgestión en salud, implica el proceso de toma de decisiones en la atención directa a las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad. Incluye la gestión de la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS).

C. ALVARADO CH.

[19] Artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS, aprobado por Decreto Supremo N°019-2024-SA.
[20] Resolución Ministerial N°939-2021/MINSA que aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional de Cuidados paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas en el Perú 2021 – 2023.
[21] Numeral 6.2.1 Conceptos y definiciones del Documento Técnico: "Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad", aprobado por Resolución Ministerial N°030-2020/MINSA.
[22] Literal h) del numeral 3.1 Definiciones del Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS), aprobado por Decreto Supremo N°019-2024-SA.
[23] Las funciones esenciales de la salud pública en las Américas. Una renovación para el siglo XXI. Marco conceptual y descripción. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

q) **Gestión de Determinantes Sociales de la Salud**[24]**:** Es la identificación y comprensión de los determinantes sociales de la salud, asimismo, involucra su abordaje mediante el desarrollo e implementación de políticas, programas y acciones concretas sobre ellos de manera intersectorial, según el ámbito de competencias y la participación activa de la comunidad, para lograr los resultados en la mejora de la salud de las poblaciones.

r) **Grupo de riesgo:** Conjunto de personas que comparten características o condiciones de salud que los hacen más vulnerables a padecer ciertas enfermedades, agravamientos o eventos adversos para la salud, en comparación con la población general.

s) **Integralidad:** Consiste en el conjunto de intervenciones de salud individual y salud pública que comprenden la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

t) **Integración clínica en la RIS**[25]**:** Es el resultado de la coordinación del Cuidado Integral de la Salud que se realiza entre los prestadores de salud de los diferentes niveles de atención de salud en el Sistema Nacional de Salud (SNS), dependiendo de la condición del usuario de salud y de la toma de decisión clínica del prestador de salud, basada en evidencia científica y con relación costo-efectividad.

u) **Intervención de salud:** Conjunto de prestaciones de salud conformado por prestaciones de salud individual de carácter promocional, preventivo, recuperativo y de rehabilitación, así como por prestaciones de salud pública, enmarcadas en las FESP (Funciones Esenciales de la Salud Publica). Las intervenciones de salud pueden ser intervenciones de salud individual o intervenciones de salud pública.

v) **Intervención de salud individual:** Es la prestación y/o conjunto de prestaciones en salud que permiten brindar el Cuidado Integral de la Salud a la persona, según corresponda, a partir de actividades de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud. Las intervenciones de salud individual pueden involucrar prestaciones de salud y/o procedimientos de salud.

w) **Intervención de salud pública:** Es la prestación y/o conjunto de prestaciones en salud dirigidas a la protección de la salud a nivel poblacional que incluye a la familia y a la comunidad; y que están relacionadas a Funciones Esenciales de la Salud Pública y la gestión de los determinantes sociales de la salud.

x) **Longitudinalidad:** Atributo de la Atención Primaria de Salud referido a que el cuidado integral de la salud esté orientado hacia las personas (no solo a las enfermedades) a lo largo del curso de sus vidas, permanente en el tiempo, así como regularidad en la relación entre el usuario de salud y un prestador de salud estable, representado por el equipo multidisciplinario de salud.

y) **Necesidades de salud**[26]**:** Conjunto de requerimientos de carácter biológico, psicológico, social y ambiental que tiene la persona, la familia y la comunidad para mantener, recuperar y/o mejorar su salud y la de su entorno, así como alcanzar una condición saludable deseable.

C. ALVARADO CH.

[24] Literal j), del artículo 3: Definiciones operativas del Reglamento de la Ley N°30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS, aprobado por Decreto Supremo N°019-2024-SA.
[25] Numeral 14.3 del artículo 14 del Reglamento de la Ley N°30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2024-SA.
[26] Numeral 5.1 definiciones operativas de la Norma Técnica de Salud N°021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", aprobado por Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA.

z) **Prestación de salud:** Es la unidad básica de la cartera de servicios de salud del Establecimiento de Salud y Servicio Médico de Apoyo, que de manera general engloba los procedimientos médicos y sanitarios que se brindan a los usuarios de salud. De acuerdo al objeto a quien se brinda comprende la prestación de salud individual y la prestación de salud pública; y de acuerdo a la naturaleza de lo que se brinda, comprende a la prestación de salud final o a la prestación de salud intermedia.

aa) **Promoción de la salud**[27]**:** Constituye un proceso social que facilita el desarrollo de capacidades en la población para ejercer un mayor control sobre los determinantes sociales de su salud y favorecer el impacto positivo en la salud individual y colectiva.

bb) **Prevención de la enfermedad**[28]**:** Son aquellas acciones y medidas orientadas a evitar la aparición o el desarrollo de enfermedades, lesiones y otros problemas de salud, o detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidos en individuos o comunidades.

cc) **Recuperación de la salud**[29]**:** Conjunto de acciones orientadas a restablecer la salud, que incluyen la evaluación clínica, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento, de la persona afectada por un daño o enfermedad. En el ciclo natural de una enfermedad, las personas afectadas pueden sanarse, mejorar, quedar con limitaciones, y en algunos casos, inevitablemente morir. Por ello, dentro de esta intervención sanitaria, la recuperación de la salud incluye los cuidados paliativos.

dd) **Recursos Tecnológicos en Salud**[30]**:** Conjunto de tecnologías en salud (TIS) con las que cuenta un establecimiento de salud, entre las que se incluyen tecnologías de protección, y promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, equipos y dispositivos médicos, medicamentos e insumos, procedimientos médico-quirúrgicos, sistemas organizacionales, tecnologías de información y comunicación en salud, tecnologías para la atención del ambiente e infraestructura.

ee) **Red Integrada de Salud (RIS)**[31]**:** Conjunto de organizaciones que presta, o hace los arreglos institucionales para prestar una cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población definida, a través de la articulación, coordinación y complementación, que rinde cuentas por los resultados sanitarios y administrativos y para el estado de salud de la población a la que sirve. Asimismo, cumple las funciones de provisión de los servicios de salud integrales a la población de su ámbito, mediante intervenciones de salud individual y salud pública, y de la gestión de los determinantes sociales de la salud.

ff) **Rehabilitación de la salud**[32]**:** Es el conjunto de acciones destinadas a lograr que las personas afectadas por alguna enfermedad puedan recuperar las capacidades que tenían antes de enfermar, hasta el nivel óptimo, de manera que puedan reinsertase en el menor tiempo posible a sus actividades habituales y productivas.

C. ALVARADO CH.

[27] Documento Técnico: Gestión para la promoción de la actividad física para la salud, aprobado por la Resolución Ministerial N° 209-2015/MINSA.
[28] Adaptado de Organización Mundial de la Salud (OMS), 1998, Disponible en https://www.paho.org/es/temas/promocion-salud
[29] Numeral 45 de las consideraciones específicas del Documento Técnico: Bases Conceptuales para el ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud, aprobado por Resolución Ministerial N°653-2020/MINSA.
[30] Numeral 5.1 de la Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", aprobado por Resolución Ministerial N° 546-2021/MINSA.
[31] Literal r, del artículo 3: Definiciones operativas del Reglamento de la Ley N°30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS, aprobado por Decreto Supremo N°019-2024-SA.
[32] Numeral 45 de las consideraciones específicas del Documento Técnico: Bases conceptuales para el ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud, aprobado por Resolución Ministerial N °653-2020/MINSA.

gg) Tratamiento[33]: Consiste en el conjunto de medidas terapéuticas dirigidas a curar, aliviar o prevenir enfermedades y sus síntomas. Puede incluir cambios en el estilo de vida, terapias farmacológicas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, psicoterapia y cuidados paliativos, entre otros. El objetivo es mejorar la calidad y expectativa de vida del paciente mediante el control o la cura de la enfermedad y el alivio del sufrimiento.

hh) Vía de cuidado integral en salud[34]: Herramienta de gestión para el cuidado integral de salud en la RIS, que define las condiciones necesarias para asegurar la integralidad y longitudinalidad en dicho cuidado para la persona, familia y comunidad, por parte de actores del Sistema Nacional de Salud (población, prestadores y financiadores) y actores de otros sectores, a partir de: a) acciones intersectoriales y sectoriales, así como intergubernamentales e interinstitucionales orientadas a promover el bienestar y desarrollo de la persona, familia y comunidad; b) servicios de salud individual y salud pública para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; y c) acciones de cuidado que se esperan del individuo para promover, mantener o restablecer la salud.

5.2 Acrónimos y Siglas

ANS	Autoridad Nacional de Salud
APS	Atención Primaria de Salud
ARS	Autoridad Regional de Salud
DIRIS LM	Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana
ECA	Ensayos clínicos aleatorizados
E.S.	Establecimiento de Salud
EsSalud	Seguro Social de Salud
FESP	Funciones Esenciales en Salud Pública
GPC	Guía de Práctica Clínica
IAFAS	Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud
MINSA	Ministerio de Salud
NTS	Norma Técnica de Salud
PEAS	Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
RHUS	Recurso Humano en Salud
RIS	Red Integrada de Salud

C. ALVARADO CH.

[33] Adaptado de Diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, 2023. Disponible en https://www.cun.es/diccionario-medico
[34] Literal w del artículo 3 numeral 3.1 Definiciones del Reglamento de la Ley N°30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS, aprobado por Decreto Supremo N°019-2024-SA.

SNS	Sistema Nacional de Salud
UPSS	Unidad Productora de Servicios de Salud
VCIS	Vía de Cuidado Integral en Salud

5.3 La RIS provee servicios de salud bajo los principios de continuidad y complementariedad del cuidado integral de la salud entre los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo que la conforman, mediante modalidades de oferta fija, móvil y telesalud, e implementa Vías de Cuidado Integral en Salud.

5.4 Los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo públicos, privados y mixtos que de manera progresiva se integren a la RIS, se articulan y coordinan para brindar las intervenciones de salud individual y de salud pública definidas en la VCIS, para el cuidado integral de salud de la persona, la familia y la comunidad.

5.5 La VCIS como herramienta de gestión para el cuidado integral de la salud, define e integra intervenciones de salud individual y de salud pública, así como acciones intersectoriales, intergubernamentales e interinstitucionales necesarias para garantizar el cuidado integral de salud de la persona, la familia y la comunidad.

5.6 Las intervenciones de salud definidas en la VCIS se conforman por prestaciones de salud individual y de salud pública establecidas en la cartera de servicios de salud de los establecimientos de salud de la RIS y fuera de ella, así como por otras prestaciones en el marco de la RIS.

5.7 La VCIS comprende tres tramos interrelacionados:

a) Para promover y mantener la salud: Orientada a fomentar la salud, eliminar, reducir o mitigar el riesgo de enfermar y generar una cultura del cuidado de la salud en la persona, familia y comunidad, mediante intervenciones de salud de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

b) Para grupos de riesgo: Dirigida a la identificación y abordaje oportuno y efectivo de los factores de riesgo que caracterizan a la población con condiciones comunes de exposición y vulnerabilidad a determinados problemas de salud.

c) Para eventos específicos: Orientada al oportuno diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de condiciones de salud específicas.

Los tres tramos de la VCIS se interrelacionan entre sí, permitiendo a la persona, familia y comunidad acceder a las intervenciones de salud individual y de salud pública que requiera de manera coordinada y oportuna. En el Anexo 1 de la presente NTS se incluye un diagrama que ilustra esta interrelación.

5.8 La VCIS en su constitución cumple con las siguientes características:

a. **Integralidad:** La VCIS describe de forma integral los procesos asistenciales y organizacionales necesarios para brindar el cuidado integral de salud a la persona, familia y comunidad, incluyendo los resultados esperados de las intervenciones de salud individual y salud pública.

b. **Contextualización:** La VCIS responde a las necesidades de salud y características particulares del entorno en donde se aplica, con el fin de asegurar su efectividad y lograr los resultados esperados.

C. ALVARADO CH.

c. **Mejor evidencia:** La VCIS incorpora las decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia científica disponible y las mejores prácticas sanitarias.

d. **Comunicación:** La VCIS fortalece la coordinación, colaboración y toma de decisiones dentro del Sistema Nacional de Salud (población, prestadores y financiadores) y con otros actores relacionados, a través de una comunicación eficaz, clara y oportuna que contribuye a mejorar la integración clínica y funcional.

e. **Mejora continua:** La VCIS contribuye a implementar procesos de calidad a partir de la evaluación de los resultados esperados, permitiendo modificar su diseño para optimizar las decisiones clínicas y la gestión organizacional.

f. **Oportunidad:** La VCIS contribuye a que la persona, familia y comunidad reciba las diferentes intervenciones de salud de acuerdo con los tiempos máximos establecidos.

g. **Complementariedad:** La VCIS permite la continuidad y articulación del cuidado integral de la salud entre Establecimientos de Salud, instituciones u organizaciones en la RIS o fuera de ella. Asimismo, contribuye al desarrollo de acciones a nivel intersectorial, intergubernamental e interinstitucional para influir positivamente en los determinantes sociales de la salud.

5.9 La VCIS considera los siguientes enfoques:

a. Centrado en la persona y su contexto familiar y comunitario: La VCIS considera las preferencias y necesidades de la persona según curso de vida. Asimismo, considera el rol de la familia y la comunidad para responder de manera integral a sus necesidades de salud.

b. Gestión integral del riesgo: La VCIS permite identificar, evaluar, mitigar y controlar los riesgos que pueden afectar la salud de la persona, familia y comunidad, mediante su detección y abordaje temprano.

c. Equidad en salud: La VCIS permite que las personas, familias y comunidades tengan acceso al cuidado integral de salud de manera equitativa e integral, independiente de su condición social, económica o cultural.

d. Territorial: La VCIS considera las características específicas de las diferentes zonas geográficas, así como las condiciones ambientales, sociales, culturales y epidemiológicas de los territorios en su elaboración e implementación. Asimismo, responde a la organización sanitaria establecida en las Unidades Territoriales Sanitarias de las RIS.

5.10 Las intervenciones de salud y prestaciones de salud identificadas en la VCIS se financian a través de las diferentes fuentes de financiamiento, a cargo del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras.

5.11 Las IAFAS financian las intervenciones de salud y prestaciones de salud definidas en la VCIS, según la cobertura de los Planes de Aseguramiento en Salud (PEAS, planes complementarios o planes específicos), acorde a la normatividad vigente.

5.12 La ANS elabora la VCIS mediante la conformación del equipo elaborador de la VCIS, conforme a lo dispuesto en la presente Norma Técnica de Salud.

C. ALVARADO CH.

5.13 La VCIS elaborada por la ANS se aprueba mediante Resolución Ministerial. La ARS o la DIRIS LM aprueba la versión adecuada de la VCIS seleccionada para su implementación en el ámbito territorial correspondiente.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 Organización para la elaboración e implementación de Vías de Cuidado Integral en Salud

6.1.1 La ANS, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública o el Instituto Nacional de Salud o la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, propone la VCIS a elaborar, considerando las Prioridades Nacionales en Salud, al Despacho Viceministerial correspondiente.

6.1.2 El Despacho Viceministerial correspondiente evalúa y da conformidad a la propuesta de elaboración de la VCIS.

6.1.3 La ANS, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública mediante sus unidades orgánicas según la condición de salud a cargo, o el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, conduce la elaboración de la VCIS conforme a la metodología establecida en la presente Norma Técnica de Salud. El Anexo 2 detalla el diagrama de flujo correspondiente a la organización, elaboración, implementación y evaluación de la VCIS.

C. ALVARADO CH.

6.1.4 La elaboración de la VCIS sigue las etapas de planeación, formulación, implementación y evaluación.

6.1.5 La VCIS se elabora utilizando las herramientas metodológicas que forman parte de la presente Norma Técnica de Salud.

6.1.6 La ARS o DIRIS LM, a través del Equipo Impulsor de la RIS y en coordinación con los Gestores de la RIS, implementa la VCIS optimizando los recursos disponibles, sin modificar las intervenciones de salud definidas en ella y asegurando el logro de sus objetivos establecidos.

6.1.7 La ANS, a través de sus órganos y unidades orgánicas, según corresponda, contribuye a la implementación de la VCIS en la RIS, en el marco de sus competencias para favorecer el cuidado integral, oportuno y continuo de la persona, familia y comunidad.

6.2 Metodología para la elaboración e implementación de Vías de Cuidado Integral en Salud

Definida la VCIS a elaborar, se sigue la siguiente metodología:

6.2.1 Etapa de Planeación

6.2.1.1 Paso 1: Conformación del equipo elaborador de la VCIS

6.2.1.1.1 La ANS, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública o el Instituto Nacional de Salud, conforma el equipo elaborador de la VCIS en

coordinación con la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional. El equipo elaborador de la VCIS está integrado por profesionales de la salud, según cuatro ejes temáticos, con el siguiente perfil mínimo:

a) Eje temático: Prestación de Servicios de Salud

a.1 Formación Académica:
- Profesionales con título profesional universitario en carreras de Ciencias de la Salud relacionado a la VCIS que se elabora.
- Estudios concluidos de postgrado en Cuidado Integral en Salud o segunda especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria o afines.

a.2 Experiencia:
- Específica mínima de 5 años en establecimientos de salud del primer nivel de atención en salud, en atención de salud directa a usuarios de los servicios de salud, de acuerdo con la VCIS que se elabora. Deseable: Experiencia en gestión clínica.
  La experiencia se considera a partir del título profesional.

b) Eje Temático: Prestación de Servicios de Salud Especializada o subespecializada

b.1 Formación Académica:
- Profesionales con título profesional universitario en carreras de Ciencias de la Salud relacionado a la VCIS que se elabora.
- Título de Segunda especialidad profesional de acuerdo con la VCIS que se elabora o Título de subespecialidad médica de acuerdo con la VCIS que se elabora.

b.2 Experiencia:
- Específica mínima de 5 años en establecimientos de salud del segundo o tercer nivel de atención en salud, en atención de salud directa a usuarios de los servicios de salud, de acuerdo con la VCIS que se elabora. Deseable: Experiencia en gestión clínica.
  La experiencia se considera a partir del título profesional.

c) Eje Temático: Metodología de la Investigación

c.1 Formación Académica:
- Profesionales con título profesional universitario en carreras de Ciencias de la Salud.
- Estudios concluidos de Maestría en epidemiología o ciencias epidemiológicas o salud pública o administración de la salud o gerencia social o salud global o investigación o afines; o segunda especialidad en Administración y Gestión en Salud o afines.
- Capacitación en síntesis de evidencia o revisiones sistemáticas o investigación en salud o evaluación de tecnologías sanitarias.

C. ALVARADO CH.

- Nivel intermedio de idioma inglés concluido, certificado o nativo.

c.2 Experiencia:
- Específica mínima de 1 año en instituciones públicas o privadas en el campo de la investigación o síntesis de evidencia científica para la toma de decisiones.
- Contar con al menos una publicación de síntesis de evidencias (revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, evaluaciones de tecnologías sanitarias, entre otros).

La experiencia se considera a partir del título profesional.

d) Eje Temático: Gestión en Salud

d.1 Formación Académica:
- Profesionales con título profesional universitario en carreras de Ciencias de la Salud.
- Estudios concluidos de post grado o Segunda especialidad profesional en Gestión en Salud o Gestión de los Servicios de Salud o Administración y Gestión en Salud o Gestión Pública o Gerencia de Servicios de Salud o Salud Pública o afines.

d.2 Experiencia:
- Específica mínima de 5 años en instituciones públicas de salud en organización de servicios de salud o gestión de la calidad en salud o gestión sanitaria o planificación de los servicios de salud o salud pública o afines.

La experiencia se considera a partir del título profesional.

C. ALVARADO CH.

6.2.1.1.2 El equipo elaborador de la VCIS está conformado, con un mínimo de 5 y máximo 9 profesionales de la salud, según las características y necesidades de la VCIS a elaborar.

6.2.1.1.3 El equipo elaborador mínimo de la VCIS se conforma de la siguiente manera:

a. Eje temático prestación de servicios de salud: un profesional de la salud.
b. Eje temático prestación de servicios de salud especializada o subespecializada: un profesional de salud.
c. Eje temático metodología de la investigación: dos profesionales de la salud.
d. Eje temático gestión en salud: un profesional de la salud.

6.2.1.1.4 La ANS, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública o el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, verifica el cumplimiento del perfil de los profesionales de la salud que integran el equipo elaborador de la VCIS y elige al coordinador del equipo, quién no debe tener conflicto de intereses

6.2.1.1.5 El coordinador del equipo elaborador de la VCIS tiene las siguientes responsabilidades:

a. Planifica y coordina las sesiones del equipo durante todo el proceso de elaboración de la VCIS.
b. Convoca y preside las sesiones del equipo elaborador.
c. Verifica la participación mínima (5 integrantes según los ejes temáticos) en cada sesión del equipo elaborador.
d. Modera las sesiones de trabajo, propiciando la participación de todos los integrantes.
e. Comunica de manera oportuna la agenda y objetivos de cada actividad a realizar por el equipo.
f. Realiza el seguimiento al cumplimiento de los plazos según cronograma establecido
g. Revisa y consolida los aportes de los integrantes del equipo elaborador de acuerdo con las herramientas metodológicas contenidas en la presente NTS.
h. Monitorea que la VCIS cumpla con los requisitos metodológicos, normativos y técnicos establecidos.
i. Evalúa la declaración de los conflictos de interés de los integrantes del equipo elaborador de la VCIS.
j. Recopila y archiva en el acervo documentario del equipo, las declaraciones de conflictos de interés de sus integrantes, al inicio y durante el proceso de elaboración en forma periódica.
k. Recopila y archiva todos los documentos de trabajo de las sesiones de elaboración de la VCIS.
l. Recopila y archiva las actas de las sesiones del equipo elaborador.
m. Participa en la elaboración del anteproyecto del Documento Normativo, que corresponde a una Guía Técnica de la VCIS elaborada y validada.
n. Realiza la entrega formal al órgano u organismo proponente, del Documento Normativo (que corresponde a la Guía Técnica de la VCIS), para la gestión de su aprobación.

El coordinador del equipo elaborador de la VCIS puede delegar en otro integrante del equipo la responsabilidad de cumplir con lo establecido en los literales f, j, k y l, de la presente disposición.

6.2.1.1.6 El equipo elaborador de la VCIS puede solicitar la colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión y/o aporte técnico de profesionales especialistas invitados, los cuales deben tener conocimientos y experiencia especializada en la materia de la VCIS que se elabora. Su participación es consultiva.

6.2.1.1.7 Las instituciones públicas, privadas y/o mixtas brindan las facilidades necesarias para la participación de los profesionales convocados para integrar los equipos elaboradores de la VCIS, según cronograma de trabajo establecido.

C. ALVARADO CH.

6.2.1.1.8 Los integrantes del equipo elaborador de la VCIS realizan declaración de conflictos de interés, considerando la estructura del Anexo 3: Formulario para Declaración de Conflictos de Interés, establecido en la presente NTS. La respuesta afirmativa a alguna de las preguntas no descalifica ni limita su participación. Cada declaración es evaluada para determinar la existencia de conflictos de interés relevantes.

6.2.1.1.9 El coordinador del equipo elaborador y sus integrantes elaboran las, actividades, tareas y cronograma respectivo, considerando la estructura del Anexo 4: Cronograma estándar para la elaboración de la VCIS.

6.2.1.1.10 Cuando un integrante del equipo elaborador de la VCIS no pueda continuar con la elaboración de la VCIS se reemplaza por otro profesional que cumpla con el perfil establecido.

6.2.1.1.11 La VCIS se elabora en un periodo no mayor a doce meses, desde la conformación del equipo elaborador.

6.2.2 Etapa de Formulación

6.2.2.1 Paso 2: Mapeo de las Intervenciones de Salud

6.2.2.1.1 Identificación de las intervenciones de salud

6.2.2.1.1.1 El equipo elaborador de la VCIS identifica las intervenciones de salud individual de la VCIS que se elabora en base a la evidencia científica, el marco normativo vigente y/o la experiencia, considerando la integralidad y continuidad del cuidado integral de la salud.

6.2.2.1.1.2 La identificación de las intervenciones de salud individual comprende:

a. El tipo de intervención de salud a la que corresponde (promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación de la salud, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos, según el alcance de la VCIS).
b. La modalidad de oferta de servicios de salud que corresponda (fija, móvil y/o telesalud).
c. El escenario de cuidado donde se brinda (establecimiento de salud, hogar, Instituciones educativas, centro laboral, comunidad, entre otros).
d. El tipo de soporte que corresponda (evidencia científica, marco normativo vigente, y/o experiencia de los integrantes del equipo elaborador de la VCIS).

6.2.2.1.1.3 El equipo elaborador identifica las intervenciones de salud individual tomando como base la herramienta 1: Identificación de las intervenciones de salud individual, contenido en la presente NTS (Anexo 5).

6.2.2.1.1.4 La identificación de las intervenciones de salud pública comprende:

C. ALVARADO CH.

a. La relación con la FESP 1, FESP 2, FESP 5, FESP 7, FESP 9, FESP 10 y FESP 11.
b. La relación con la gestión de los determinantes sociales de la salud.
c. La modalidad de oferta de servicios de salud que corresponda (fija, móvil y/o telesalud).
d. El tipo de soporte que corresponda (marco normativo vigente, evidencia científica y/o experiencia del equipo elaborador de la VCIS).

6.2.2.1.1.5 El equipo elaborador identifica las intervenciones de salud pública tomando como base la herramienta 2: Identificación de las intervenciones de salud pública, contenido en la presente NTS (Anexo 6).

6.2.2.1.2 Descripción de las Intervenciones de Salud

6.2.2.1.2.1 El equipo elaborador, previo acuerdo, caracteriza y describe las intervenciones de salud individual y salud pública identificadas, considerando los criterios de: a quién corresponde, en dónde se ejecuta y cómo se concretan, tomando como base la estructura y componentes de la herramienta 3: Descripción de intervenciones de salud, contenido en la presente NTS (Anexo 7).

6.2.2.1.3 Preselección de las Intervenciones de Salud

6.2.2.1.3.1 Cada integrante del equipo elaborador evalúa las intervenciones de salud individual y salud pública teniendo en consideración los criterios de relevancia y factibilidad y tomando como base la estructura de la herramienta 4: Preselección de intervenciones de salud, contenido en la presente NTS (Anexo 8).

6.2.2.1.3.2 En acuerdo técnico el equipo elaborador preselecciona las intervenciones de salud individual y de salud pública que cumplan los criterios antes mencionados y excluye las demás.

6.2.2.1.3.3 Las intervenciones de salud individual y de salud pública preseleccionadas se consideran en el siguiente paso.

6.2.2.2 Paso 3: Revisión de la evidencia científica o Documento Normativo vigente

6.2.2.2.1 El equipo elaborador soporta las intervenciones de salud individual y de salud pública preseleccionadas en evidencia científica y/o documentos normativos vigentes.

6.2.2.2.2 El equipo elaborador de la VCIS, como primer insumo en la búsqueda de evidencia, identifica las guías de práctica clínica (GPC) aprobadas por el Ministerio de Salud, el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de

C. ALVARADO CH.

Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud, las Guías de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, teniendo como base la estructura y criterios de la herramienta 5: Selección de Guías de Práctica Clínica, contenido en la presente NTS (Anexo 9).

6.2.2.2.3 La GPC no elaborada bajo la metodología vigente del Ministerio de Salud o la GPC que no cumpla con los criterios de selección, se evalúa con la herramienta AGREE II. El instructivo del Anexo 9 de la presente NTS, detalla la puntuación de la calidad en la evaluación AGREE II.

6.2.2.2.4 El equipo elaborador de la VCIS como segundo insumo identifica los documentos normativos vigentes aprobados por el Ministerio de Salud, de cumplimiento obligatorio en lo que resulte aplicable.

6.2.2.2.5 En ausencia de GPC o cuando no cumple con los criterios de selección, o la evaluación AGREE II, o en ausencia de documento normativo relacionado con el alcance de la VCIS o cuando este supera los diez años de antigüedad, el equipo elaborador revisa la literatura científica y considera lo siguiente:

a) Construcción de la estrategia PICO y generación de la pregunta de investigación para cada intervención de salud preseleccionada conforme a la estructura de la herramienta 6: Construcción de la Estrategia PICO, contenido en la presente NTS (Anexo 10).
b) Estrategia de búsqueda de evidencia científica, conforme a la estructura de la herramienta 7: Estrategia de búsqueda de evidencia científica (Anexo 11).
c) Selección y valoración de la evidencia científica (revisiones sistemáticas y metaanálisis), conforme a la estructura de la herramienta 8: Selección y valoración de la evidencia científica, contenido en la presente NTS (Anexo 12).
d) Extracción de datos relevantes para la elaboración de la VCIS.

6.2.2.2.6 En caso excepcional, cuando una intervención de salud se basa en otro tipo de evidencia y existe consenso para su incorporación en la VCIS, el coordinador del equipo elaborador deja constancia formal del argumento consensuado, detallando las razones y los integrantes que participan en la toma de la decisión, conforme a la estructura del Anexo 13: Criterios para la incorporación excepcional de intervenciones de salud.

6.2.2.3 Paso 4: Selección de las Intervenciones de Salud

6.2.2.3.1 Cada integrante del equipo elaborador califica las intervenciones de salud individual y salud pública considerando cuatro criterios: a) evidencia y calidad de la evidencia, b) balance riesgo/beneficio de la intervención de salud, c) costo/beneficio y d) Equidad, tomando como base la

estructura y componentes de la herramienta 9: Calificación y selección de intervenciones de salud, contenido en la presente NTS (Anexo 14).

6.2.2.3.2 Las intervenciones de salud que se califican según los cuatro criterios antes mencionados, son:

- Intervención de salud identificada en GPC internacional que cumple con la puntuación establecida para el AGREE II.
- Intervención de salud identificada en GPC de Hospitales Nacionales (Perú) que cumple con la puntuación establecida para el AGREE II.
- Intervención de salud incluida en la revisión de literatura científica.
- Intervención de salud basada en otro tipo de evidencia que cuenta con consenso para su incorporación en la VCIS.

6.2.2.3.3 La intervención de salud que se sustenta en base a los criterios de la revisión de evidencia científica y documento normativo vigente con antigüedad menor a diez años se selecciona automáticamente para el paso 5, sin aplicar los criterios de selección del numeral 6.2.2.3.1 de la presente NTS.

6.2.2.3.4 El equipo elaborador analiza los resultados de la calificación de las intervenciones de salud individual y salud pública y seleccionan aquellas que formarán parte de la VCIS.

6.2.2.4 Paso 5: Identificación y caracterización de los resultados esperados

6.2.2.4.1 El equipo elaborador formula y caracteriza los resultados esperados, metas, hitos e indicadores de las intervenciones de salud seleccionadas, teniendo como base la estructura y contenido de la herramienta 10: Identificación y caracterización de los resultados esperados, contenido en la presente NTS (Anexo 15).

6.2.2.4.2 El equipo elaborador identifica el resultado esperado el cual constituye el efecto deseado en la persona, familia y comunidad como consecuencia de la implementación de las intervenciones de salud individual y de salud pública seleccionadas en la VCIS.

6.2.2.4.3 El equipo elaborador identifica y/o formula los hitos los cuales corresponden a logros significativos que marcan momentos trazadores en el proceso de implementación de la VCIS y están vinculados al logro de los resultados esperados. Los hitos recogen una o varias intervenciones de salud y pueden referirse a aspectos como coberturas, accesibilidad, pertinencia técnica y cultural, oportunidad, entre otros.

6.2.2.4.4 El equipo elaborador diseña y/o identifica los indicadores para cada hito de acuerdo con su tipo: estructura, proceso o resultado.

6.2.2.5 Paso 6: Construcción de la matriz de intervenciones de salud

6.2.2.5.1 El equipo elaborador registra las intervenciones de salud individual y salud pública seleccionadas considerando cinco criterios: a) caracterización de la condición de salud, b) soporte de evidencia científica, c) intervenciones de salud, d) identificación y descripción operativa de los resultados esperados y e) barreras y facilitadores para la implementación, utilizando la herramienta 11: Matriz de intervenciones de salud, contenido en la presente NTS (Anexo 16).

6.2.2.6 Paso 7: Construcción del diagrama de intervenciones de salud

6.2.2.6.1 El equipo elaborador en concordancia con la matriz de intervenciones de salud (paso 6) elabora el diagrama de intervenciones de salud individual y el diagrama de intervenciones de salud pública.

Diagrama de intervenciones de salud individual

C. ALVARADO CH.

6.2.2.6.2 El equipo elaborador grafica el diagrama de intervenciones de salud individual teniendo como base la estructura de la herramienta 12: Diagrama de intervenciones de salud individual, contenido en la presente NTS (Anexo 17), considerando en su diseño la secuencia lógica del cuidado integral de la salud e incorpora las intervenciones de salud seleccionadas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y rehabilitación de la salud, según corresponda.

6.2.2.6.3 El equipo elaborador incorpora en el diagrama información respecto a quién, dónde y cómo se ejecuta las intervenciones de salud, los parámetros de estandarización de la práctica clínica, los hitos y los tiempos de oportunidad críticos del proceso de cuidado, de acuerdo con la VCIS que se elabora.

6.2.2.6.4 El equipo elaborador grafica el diagrama de intervenciones de salud individual utilizando herramientas digitales para modelar procesos, para facilitar su comprensión y visualización.

Diagrama de intervenciones de salud pública

6.2.2.6.5 El equipo elaborador grafica el diagrama de intervenciones de salud pública considerando las intervenciones de salud de promoción de la salud y/o prevención de la enfermedad, según corresponda.

6.2.2.6.6 El equipo elaborador enlista las intervenciones de salud pública de acuerdo con el escenario de cuidado y actor/es

responsables de su ejecución, teniendo como base la estructura de la herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud pública, contenido en la presente NTS (Anexo 18).

6.2.2.7 Paso 8: Validación y retroalimentación de la VCIS

6.2.2.7.1 El equipo elaborador gestiona la validación de la VCIS que consta de dos etapas: validación interna y validación externa, considerando lo descrito en el Anexo 19: Pasos para la validación de la Vía de Cuidado Integral en Salud, contenido en la presente NTS.

Validación Interna

6.2.2.7.2 El equipo elaborador identifica y convoca a las unidades orgánicas, órganos y/o organismos del Ministerio de Salud involucrados en el objetivo y alcance de la VCIS para validar el cumplimiento de lo siguiente:

a. Intervenciones de salud seleccionadas con soporte en la evidencia científica disponible, marco normativo vigente o experiencia fundamentada del equipo elaborador de la VCIS.
b. Contenidos de la matriz de intervenciones de salud coherentes, comprensibles y claros.
c. Contenidos del diagrama de intervenciones de salud coherentes, comprensibles y claros.

6.2.2.7.3 El equipo elaborador valora los aportes realizados y ajusta los contenidos de la VCIS, según corresponda, de acuerdo con los resultados de la validación interna.

Validación Externa

6.2.2.7.4 Posterior a la validación interna, el equipo elaborador identifica y convoca a actores con experiencia y conocimiento entre los que destacan: especialistas, docentes de Instituciones formadoras de recursos humanos en salud, representantes de los colegios profesionales de las ciencias de la salud, representantes del Gobierno Nacional, Regional o Local, organizaciones que representen a los usuarios de salud, IAFAS, entre otros según corresponda a la VCIS que se elabora, para validar el cumplimiento de lo siguiente:

a. Intervenciones de salud seleccionadas con soporte en la evidencia científica disponible, marco normativo vigente o experiencia fundamentada del equipo elaborador de la VCIS.
b. Contenidos de la matriz de intervenciones de salud coherentes, comprensibles y claros.
c. Contenidos del diagrama de intervenciones de salud coherentes, comprensibles y claros.

6.2.2.7.5 El equipo elaborador valora la pertinencia con la información obtenida y realiza el ajuste en la VCIS, según corresponda, de acuerdo con los resultados de la validación externa.

C. ALVARADO CH.

6.2.2.7.6 El equipo elaborador presenta el Anteproyecto de Documento Normativo que corresponde a una Guía Técnica de la VCIS elaborada y validada, al órgano u organismo proponente para gestionar la aprobación de la VCIS conforme a la normativa vigente.

6.2.3 Etapa de Implementación

6.2.3.1 Paso 9: Implementación de la VCIS

6.2.3.1.1 La VCIS se implementa en la RIS. La implementación de la VCIS contribuye al fortalecimiento del proceso de integración clínica en la RIS para el cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad.

6.2.3.1.2 La RIS identifica y prioriza la VCIS aprobada por el Ministerio de Salud, para su implementación, considerando el perfil de salud de su ámbito territorial y otros criterios locales según corresponda.

6.2.3.1.3 La implementación de la VCIS considera las características específicas del territorio y se articula con la organización sanitaria establecida en las Unidades Territoriales Sanitarias de la RIS.

C. ALVARADO CH.

6.2.3.1.4 La RIS adecúa la VCIS priorizada, considerando las características, particularidades o circunstancias específicas de su ámbito territorial y la continuidad del cuidado integral de la salud. La adecuación de la VCIS se realiza considerando el Anexo 20: Pasos para la adecuación de la VCIS en la RIS, contenido en la presente NTS.

6.2.3.1.5 La RIS eleva a la ARS o DIRIS LM la VCIS adecuada para su aprobación mediante acto resolutivo.

6.2.3.1.6 Los Gestores de la RIS en coordinación con la ARS o DIRIS LM elaboran el Plan de implementación de la VCIS adecuada.

6.2.3.1.7 El Plan de Implementación de la VCIS adecuada, contiene objetivos, actividades y tareas para la entrega de las intervenciones de salud definidas en la VCIS.

6.2.3.1.8 La RIS inicia la implementación de la VCIS adecuada con los recursos disponibles.

6.2.3.1.9 Los Gestores de la RIS, en coordinación con la ARS o DIRIS LM gestiona los Recursos Humanos en Salud, los Recursos Tecnológicos en Salud y otros recursos adicionales necesarios para la implementación de la VCIS adecuada.

6.2.3.1.10 La ARS o DIRIS LM en coordinación con los Gestores de la RIS establecen acuerdos a nivel sectorial e intersectorial, interinstitucional e intergubernamental según corresponda, para la implementación de la VCIS adecuada.

6.2.3.1.11 La implementación de la VCIS utiliza la Historia Clínica Electrónica para registrar y compartir la información del usuario de los servicios de salud, con el fin de asegurar la trazabilidad, integralidad y continuidad del cuidado.

6.2.3.1.12 Los Gestores de la RIS realizan el monitoreo continuo de la ejecución de las actividades y tareas programadas en el Plan de implementación de la VCIS adecuada, considerando el estado (realizado, en proceso o por realizar), fecha, responsable y observaciones, según corresponda.

6.2.3.1.13 La RIS implementa de manera progresiva la VCIS adecuada en un plazo no mayor de dieciocho (18) meses a partir de su aprobación por la ARS o DIRIS LM. En el Anexo 21 se muestra ejemplos ilustrativos del recorrido de la persona en la VCIS.

6.2.4 Etapa de Evaluación

6.2.4.1 La ARS o DIRIS LM evalúa de forma semestral y anual los hitos, indicadores y metas definidas en la VCIS para determinar la eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y contribución al cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad.

6.2.4.2 La ARS o DIRIS LM evalúa de forma semestral y anual la ejecución del Plan de Implementación de la VCIS identificada, priorizada y adecuada al ámbito territorial.

C. ALVARADO CH.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1 NIVEL NACIONAL:

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, es responsable de la difusión de la presente Norma Técnica de Salud hasta el nivel regional y Lima Metropolitana, así como brindar asistencia técnica para su implementación, supervisar su cumplimiento y evaluar su implementación.

7.2 NIVEL REGIONAL:

Las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud y las Direcciones de Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana, son responsables de la difusión, asistencia técnica, implementación y supervisión del cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud en el ámbito de su competencia.

7.3 NIVEL LOCAL:

Los Gestores de la RIS son responsables de la implementación, aplicación y cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud, según corresponda.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

8.1 La ANS actualiza la VCIS cada tres a cinco años como máximo. Esta actualización se realiza cuando se cuenta con nueva evidencia científica, actualización de las GPC o documentos normativos, y el contexto sanitario, según corresponda.

8.2 La VCIS en proceso de elaboración con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Norma Técnica de Salud es objeto de revisión y análisis por parte de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, con el propósito de adecuarla a sus disposiciones, según corresponda.

8.3 Los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo del Seguro Social de Salud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario – INPE; los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo privados y mixtos que se integran progresivamente a la RIS, aplican las disposiciones establecidas en la presente Norma Técnica de Salud, en lo que corresponda.

8.4 El proceso de referencia y contrarreferencia utiliza el diagrama de intervenciones de salud individual de la VCIS para asegurar la integralidad, oportunidad y continuidad del cuidado integral de salud.

C. ALVARADO CH.

IX. ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de la interrelación de los tramos de la Vía de Cuidado Integral en Salud en la RIS.

Anexo 2: Diagrama de flujo de la organización, elaboración, implementación y evaluación de la VCIS.

Anexo 3: Formulario para declaración de conflictos de interés.

Anexo 4: Cronograma estándar para la elaboración de VCIS.

Anexo 5: Herramienta 1: Identificación de intervenciones de salud individual (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 6: Herramienta 2: Identificación de intervenciones de salud pública (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 7: Herramienta 3: Descripción de intervenciones de salud (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 8: Herramienta 4: Preselección de intervenciones de salud (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 9: Herramienta 5: Selección de Guías de Práctica Clínica (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 10: Herramienta 6: Construcción de la estrategia PICO (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 11: Herramienta 7: Estrategia de búsqueda de evidencia científica (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 12: Herramienta 8: Selección y valoración de la evidencia científica (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 13: Criterios para la incorporación excepcional de intervenciones de salud.

Anexo 14: Herramienta 9: Calificación y selección de intervenciones de salud (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 15: Herramienta 10: Identificación y caracterización de los resultados esperados (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 16: Herramienta 11: Matriz de intervenciones de salud (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 17: Herramienta 12: Diagrama de intervenciones de salud individual (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 18: Herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud pública (incluye instructivo y ejemplo).

Anexo 19: Pasos para la validación de la Vía de Cuidado Integral en Salud.

Anexo 20: Pasos para la adecuación de la VCIS en la RIS.

Anexo 21: Ejemplo ilustrativo del recorrido de la persona en la VCIS.

C. ALVARADO CH.

ANEXO 1

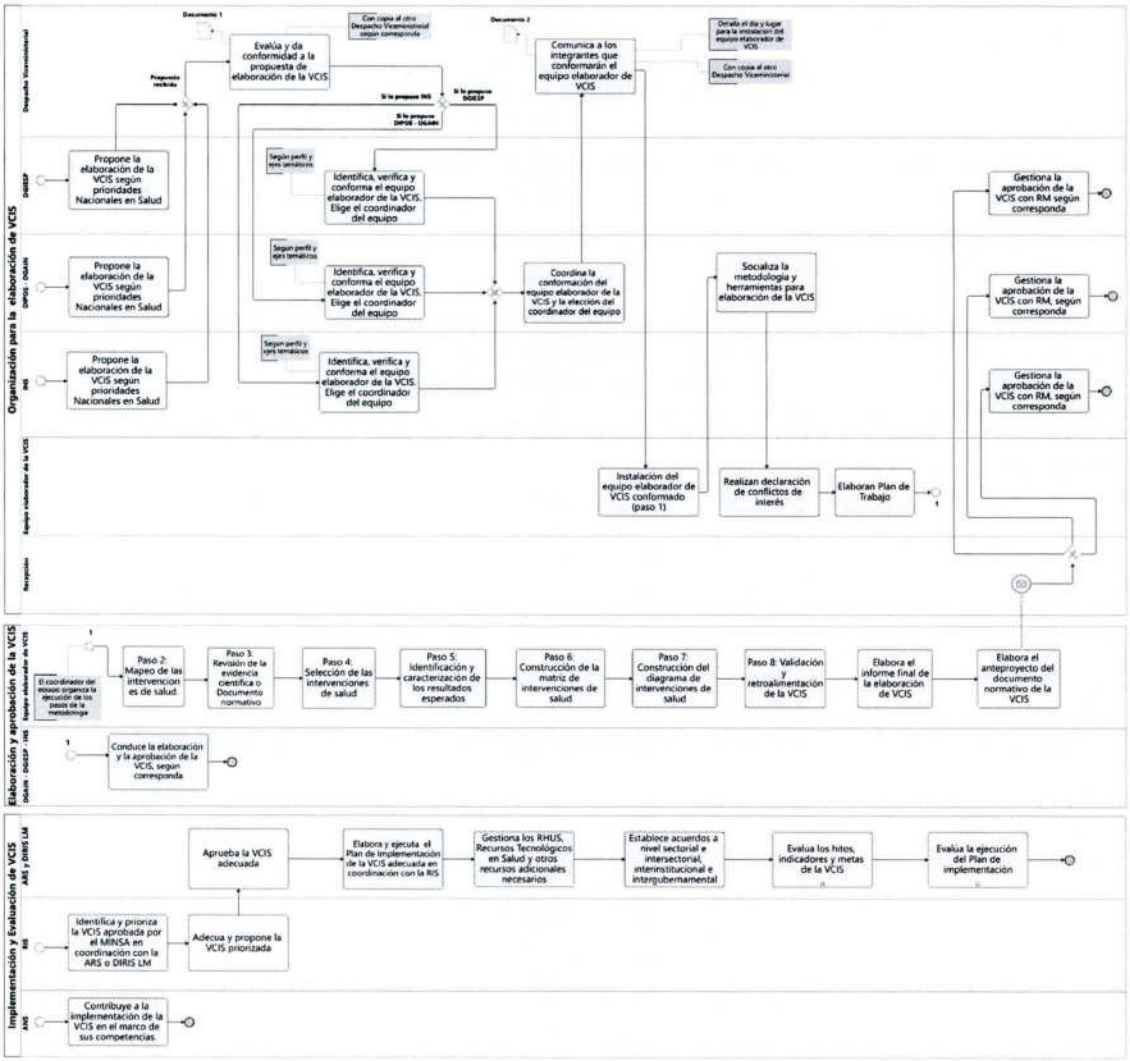
Diagrama de la interrelación de los tramos de la Vía de Cuidado Integral en Salud en la RIS.



Elaborado por: Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional.

ANEXO 2

Diagrama de flujo de la organización, elaboración, implementación y evaluación de la VCIS.



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO 3

Formulario para Declaración de Conflictos de Interés

Para asegurar la más alta integridad y confianza pública en las actividades del equipo elaborador de VCIS, se requiere que los integrantes declaren cualquier circunstancia que pueda propiciar un conflicto de interés relacionado con el tema que se está tratando y en el que usted está participando.

Todos los integrantes del equipo elaborador deben declarar cualquier circunstancia que pudiera representar un potencial conflicto de interés. Usted debe declarar mediante este formulario cualquier interés financiero, profesional u de otro tipo relevante al tema objetivo del trabajo o reunión actual. Usted también debe declarar los intereses relevantes de sus familiares inmediatos que pudieran ser percibidos indebidamente influyentes en su juicio (por ejemplo, empleador, asociados profesionales cercanos, departamento o unidad administrativa).

Complete este formulario antes de participar en la reunión o cualquier actividad del equipo elaborador. Usted también debe informar oportunamente al coordinador del equipo elaborador cualquier cambio de la información que presente hoy. Todos los integrantes deben completar este formulario antes de confirmarse su participación en las actividades o reuniones.

El responder con un "sí" a una pregunta en este formulario no descalifica automáticamente o limita su participación en cualquier actividad. Sus respuestas serán revisadas para determinar si usted tiene conflictos de interés relevantes a la materia que se está tratando.

Todos los potenciales intereses serán revelados a los otros participantes al inicio de la actividad y usted será consultado de existir algún cambio.

Si usted no puede o no desea revelar los detalles de un interés que plantee un conflicto real o percibido, usted debe declarar que un potencial conflicto de interés puede existir y el coordinador puede decidir que usted sea completamente recusado de la reunión o del trabajo, después que usted sea informado.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

Nombre:
Institución:
Correo electrónico:
Nombre de la VCIS:

Por favor conteste cada una de las preguntas. Si su respuesta a cualquiera de ella es "sí", describa brevemente las circunstancias en la última página de este formulario (ítem 8).

El término "sí" se refiere a usted y a sus familiares más cercanos (esposa/o, o pareja con quien usted tenga una relación personal o similar y sus hijos). "Entidad comercial" incluye cualquier negocio o asociación industrial, institución de investigación u otra empresa cuyo financiamiento es derivado principalmente de fuentes comerciales con un interés relacionado al tema o materia de la reunión o trabajo. "Organización" incluye una organización gubernamental, internacional o sin fines de lucro. "Reuniones" incluye una serie de reuniones.

1. Empleo y consultorías

En los últimos 4 años, ha recibido usted algún tipo de remuneración de una entidad comercial o de alguna otra organización con interés en el área objeto del presente equipo elaborador.

1a Empleado	Sí	No
1b Consultor (incluye servicios de asesoría técnica entre otros)	Sí	No

2. Apoyo a Investigación

En los últimos 4 años, usted o su unidad de investigación ha recibido financiamiento de una entidad comercial o de otro tipo de organización con intereses relacionados al área de estudio del presente equipo elaborador.

2a Apoyo en investigación, incluye financiamiento, colaboración, auspicio, y otro tipo de transferencia de fondos	Sí	No
2b Apoyo no monetario valorado en más de S/. 1000 en total (incluye equipamiento instalaciones, asistentes de investigación, pago de viajes a reuniones de trabajo, etc.)	Sí	No
2c Apoyo (incluye honorarios) por pertenecer a un grupo de conferencistas, dar conferencias, o entrenamiento para instituciones comerciales u otras organizaciones con algún tipo de interés en el área de estudio del presente equipo elaborador.	Sí	No

3. Intereses de inversión

Tiene usted actualmente inversiones (valoradas en más de S/. 10,000) en una institución comercial con algún interés en el área de estudio del presente equipo elaborador. Por favor incluir inversiones indirectas.



3a Acciones, bonos y otras opciones de manejo de valores.	Sí	No
3b Intereses en empresas comerciales (por ejemplo: propiedades, asociaciones, empresas conjuntas, membresías o manejo de interés de empresas)	Sí	No

4. Propiedad Intelectual

Tiene usted derechos sobre alguna propiedad intelectual que puede ser beneficiada o perjudicada por los resultados del presente equipo elaborador.

4a Patentes, marcas, o derechos de autor (incluyendo solicitudes pendientes)	Sí	No
4b Propiedad sobre "conocimientos de cómo se produce" en una materia, tecnología, o proceso.	Sí	No

5. Posiciones o declaraciones públicas

5a Como parte de un proceso regulatorio, legislativo o judicial, ha usted proveído una opinión o testimonio de experto relacionado al área de estudio del presente equipo elaborador para una entidad comercial u otro tipo de organización.	Sí	No
5b Ha ocupado usted algún cargo o puesto de trabajo en alguna entidad, de forma remunerada o no remunerada, en la cual usted habrá representado los intereses o defendido alguna posición relacionados al área de estudio del presente equipo elaborador.	Sí	No

6. Información adicional

6a Si no lo ha declarado aún, ha trabajado usted para algún competidor del producto del área de estudio del presente equipo elaborador, o su participación en el equipo elaborador le permitirá acceder a información confidencial de propiedad de un competidor o crear para usted una ventaja competitiva personal, profesional, financiera o de negocios.	Sí	No
6b En su conocimiento, el resultado del presente equipo elaborador podría beneficiar o afectar adversamente los intereses de una tercera parte con quien usted tiene intereses comunes sustanciales en el ámbito personal, profesional, financieros o de negocios.	Sí	No
6c Excluyendo al Ministerio de Salud, alguna entidad ha pagado o contribuido con sus gastos de traslado en conexión con este equipo elaborador.	Sí	No
6d Ha recibido usted algún pago (aparte de costos de traslado) u honorarios para hablar públicamente en la materia de este equipo elaborador.	Sí	No
6e Existe algún aspecto en su historial o circunstancias personales no abordado aun que puedan ser percibidos como que pueden influenciar en su objetividad e independencia.	Sí	No

7. Tabaco, Alcohol, y Comida Rápida (responde estas preguntas sin considerar su implicancia con el área de interés del presente equipo elaborador)



En los últimos 4 años ha sido empleado o recibido apoyo para investigación u otra forma de financiamiento o ha tenido alguna otra relación profesional con alguna entidad directamente involucrada con la producción, manufactura, distribución o venta de tabaco, alcohol o comida rápida o representados sus intereses de alguna de estas entidades	Sí	No

8. Explicación de las respuestas afirmativas

Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores fue un "sí", describa las circunstancias en que esto se ha dado en el siguiente cuadro. Si usted no describe la naturaleza del potencial conflicto de interés o si usted no describe la magnitud o valor involucrado cuando sea relevante, el conflicto será asumido como significativo.

Núm. 1-4 Tipo de interés, número de pregunta y categoría (ej.: propiedad intelectual, 4a derechos de autor) y una descripción básica de los detalles	Nombre de la compañía, organización o institución	Pertenece a usted, un miembro de su familia, unidad de investigación u otro	Cantidad de ingreso o valor de interés (si no se especifica se asumirá como significativo)	Interés actual (o año en que terminó)

Núm. 5-6: Describe el tema las circunstancias específicas, las partes involucradas y cualquier otro detalle relevante

Consentimiento a revelación de información

Al completar y firmar este formato, doy consentimiento a que se revele cualquier potencial conflicto de interés a los otros integrantes del equipo elaborador y en el reporte de resultados del producto de trabajo.

Declaración

Yo declaro por mi honor que la información anteriormente descrita es verdadera y completa hasta donde tengo conocimiento.

Si hubiera algún cambio en la información provista, lo notificaré inmediatamente al personal debidamente responsable y llenaré una nueva declaración de conflicto de interés que describa los cambios ocurridos. Esto incluye cualquier cambio antes y durante las reuniones de trabajo, así como durante el periodo de publicación de los resultados obtenidos o cualquier actividad concerniente al tema de este equipo elaborador.

(Tomado del formato de conflicto de intereses de la Organización Panamericana de la Salud)



Fecha:

Firma:

ANEXO 4

Cronograma estándar para la elaboración de la VCIS

CRONOGRAMA ESTÁNDAR DEL EQUIPO ELABORADOR DE LA VCIS				
Etapa de Planeación	**Paso 1: Conformación del equipo elaborador de la VCIS**			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Declaración de conflictos de interés de todos los integrantes del equipo elaborador.	Equipo elaborador formalizado y organizado		
	2. Homologación de conocimientos sobre la metodología y herramientas para la elaboración de VCIS.			
Etapa de Formulación	**Paso 2: Mapeo de las intervenciones de salud**			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Identificación de las intervenciones de salud individual.	Intervenciones de salud preseleccionadas		
	2. Identificación de las intervenciones de salud pública.			
	3. Descripción de las intervenciones de salud.			
	4. Preselección de las intervenciones de salud.			
	Paso 3: Revisión de la evidencia científica y documento normativo vigente			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Selección de Guías de Práctica Clínica	Evidencia científica y documento normativo vigente seleccionado		
	2. Identificación de Documentos normativos vigentes.			
	3. Construcción de la estrategia PICO*.			
	4. Estrategia de búsqueda de evidencia científica*.			
	5. Selección y valoración de la evidencia científica*.			
	Paso 4: Selección de las intervenciones de salud			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Calificación de las intervenciones de salud según criterios.	Intervenciones de salud seleccionadas		

	2. Análisis de la calificación de las intervenciones de salud.			
	3. Selección de las intervenciones de salud.			
	Paso 5: Identificación y caracterización de los resultados esperados			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Identificación de los resultados esperados, metas e hitos.	Resultados esperados, hitos e indicadores identificados.		
	2. Identificación de los indicadores por cada hito y su responsable.			
	Paso 6: Construcción de la matriz de intervenciones de salud			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Caracterización de la condición de salud.	Matriz de intervenciones de salud elaborada		
	2. Soporte de evidencia científica y documento normativo vigente.			
	3. Caracterización de las intervenciones de salud.			
	4. Identificación y caracterización de los resultados esperados.			
	5. Identificación de barreras y facilitadores.			
	Paso 7: Construcción del diagrama de intervenciones de salud			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Construcción del diagrama de intervenciones de salud individual.	Diagrama de intervenciones de salud elaborado		
	2. Construcción del diagrama de intervenciones de salud pública.			
	Paso 8: Validación y retroalimentación de la VCIS			
	Actividades/Tareas	**Producto**	**Fecha**	**Reporte de cumplimiento**
	1. Identificación y convocatoria de los órganos y organismos públicos para la validación interna.	VCIS validada		
	2. Validación interna según criterios establecidos.			
	3. Ajuste de la VCIS (si corresponde)			

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

	4. Identificación y convocatoria de los actores con experiencia y conocimiento en la VCIS para la validación externa.			
	5. Validación externa según criterios establecidos.			
	6. Ajuste de la VCIS (si corresponde).			
	7. Presentación de los resultados de la validación interna y externa.			
	8. Informe final de la elaboración de la VCIS.			

* Sólo en ausencia de GPC según los criterios establecidos.

C. ALVARADO CH.

ANEXO 5

Herramienta 1: Identificación de intervenciones de salud individual

Herramienta 1: Identificación de intervenciones de salud individual							
VCIS							
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Tipo de oferta de servicios de salud**			**Tipo de soporte**		
		Fija	**Móvil**	**Telesalud**	**Documento normativo**	**Evidencia científica**	**Experiencia**
Promoción de la salud							
Prevención de la enfermedad							
Diagnóstico							
Tratamiento							
Rehabilitación de la salud							
Cuidados Paliativos							

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 1: Identificación de las intervenciones de salud individual.

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de identificación de las intervenciones de salud individual de la VCIS que se elabora.

El equipo elaborador en sesión y con previo conocimiento del objetivo de la actividad, en base a la evidencia científica, el marco normativo vigente y/o a su experiencia, considerando las Guías de Práctica Clínica, Documentos Normativos vigentes, el Plan Esencial de Aseguramiento, documentos relacionados al presupuesto por resultados, entre otros, identifica y plantea, previo acuerdo, las intervenciones de salud individual para la VCIS que se elabora, considerando su alcance, la integralidad y continuidad del cuidado integral de la salud.

Las intervenciones de salud individual identificadas se organizan en la herramienta 1 considerando lo siguiente:

- **Tipo de intervención de salud**
  Identifique la intervención según corresponda: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación de la salud, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos, según corresponda.

- **Intervención de salud individual**
  Consigne la denominación de la intervención de salud en forma breve, clara y nominal (según indicaciones de redacción del presente instructivo).

- **Modalidad de oferta de servicios de salud**
  Marque con un aspa (X) una o varias opciones, según corresponda: Oferta fija de salud, oferta móvil de salud y/o telesalud.

- **Tipo de soporte**
  Marque con un aspa (X) una o varias opciones, según corresponda: Evidencia científica, Documento Normativo y/o experiencia de los integrantes del equipo elaborador, según corresponda.

C. ALVARADO CH.

Las intervenciones de salud individual identificadas consideran las siguientes alternativas excluyentes:

- **Promoción de la salud:** Constituye un proceso social que facilita el desarrollo de capacidades en la población para ejercer un mayor control sobre los determinantes sociales de su salud y favorecer el impacto positivo en la salud individual y colectiva.

- **Prevención de la enfermedad:** Son aquellas acciones y medidas orientadas a evitar la aparición o el desarrollo de enfermedades, lesiones y otros problemas de salud, o detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidos en individuos o comunidades.

- **Recuperación de la salud:** Conjunto de acciones orientadas a restablecer la salud, que incluyen la evaluación clínica, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento, de la persona afectada por un daño o enfermedad. En el ciclo natural de una enfermedad, las personas afectadas pueden sanarse, mejorar, quedar con limitaciones, y en algunos casos, inevitablemente morir. Por ello, dentro de esta intervención de salud, la recuperación de la salud incluye los cuidados paliativos.

  - **Diagnóstico:** Tienen como objetivo la identificación de una enfermedad, trastorno o síndrome, habitualmente por su cuadro clínico, con o sin el concurso de los resultados de las exploraciones complementarias.

- **Tratamiento:** Consiste en el conjunto de medidas terapéuticas dirigidas a curar, aliviar o prevenir enfermedades y sus síntomas. Puede incluir cambios en el estilo de vida, terapias farmacológicas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, psicoterapia y cuidados paliativos, entre otros.

- **Cuidados Paliativos**: Es la atención que se ofrece a pacientes y familias, que sufren alguna enfermedad severa, generalmente crónica, progresiva, incurable e intratable, que limita o acorta la vida, y que se acompaña de una serie de síntomas y signos que requieren tratamiento.

- **Rehabilitación de la salud:** Es el conjunto de acciones destinadas a lograr que las personas afectadas por alguna enfermedad puedan recuperar las capacidades que tenían antes de enfermar, hasta el nivel óptimo, de manera que puedan reinsertase en el menor tiempo posible a sus actividades habituales y productivas.

Las modalidades de oferta de servicios de salud de las intervenciones de salud individual identificadas consideran las siguientes alternativas no excluyentes:

- **Oferta Fija en salud:** Es la modalidad de la oferta de servicios de salud que se brinda en instalaciones inmuebles. Lo constituye el E.S. y el S.M.A. que se organizan y funcionan en una infraestructura inmueble de naturaleza permanente.

- **Oferta Móvil en salud**: Es la modalidad de la oferta de servicios de salud que brinda el personal de la salud que se desplaza temporalmente al lugar donde se encuentra la persona, familia o comunidad, a quienes se les va a proveer prestaciones de salud, sea con recursos de la oferta móvil en salud o con recursos de la comunidad a la que se desplaza.

- **Telesalud:** Servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación-TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población. Este servicio se efectúa considerando los siguientes ejes de desarrollo de la telesalud: la prestación de los servicios de salud, la gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística; y el fortalecimiento de capacidades al personal de la salud, entre otros.

El tipo de soporte de las intervenciones de salud identificadas consideran las siguientes alternativas no excluyentes:

- **Evidencia científica**: Intervenciones de salud identificadas en información científica obtenida de fuentes confiables y sometida a evaluación crítica. Se considera: Guías de Práctica Clínica, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohortes, estudios de casos y controles, y series o reporte de casos, entre otros. Se excluye lo correspondiente a la experiencia profesional personal.

- **Documento Normativo**: Intervenciones de salud identificadas en documentos normativos aprobados por el Ministerio de Salud que son de obligatorio o referencial cumplimiento. Se considera Normas Técnicas de Salud (NTS), Documentos Técnicos, Guías Técnicas y Directivas Sanitarias vigentes.

- **Experiencia**: Intervenciones de salud identificadas a partir del conocimiento adquirido a través de la práctica profesional en contextos reales, sustentados principalmente en la observación clínica y en el juicio individual. Se considera: opinión de expertos, anécdotas clínicas o casos aislados.

A continuación, se citan algunos ejemplos, de acuerdo con las intervenciones de salud:

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

- **Promoción de la salud:** Promoción de estilos de vida saludable para el control de factores de riesgo de cáncer de mama, difusión del cuidado de la salud oral, Consejería en la importancia del autocuidado y los estilos de vida saludable.

- **Prevención de la enfermedad:** Tamizaje laboratorial para la identificación de riesgo de diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles, Tamizaje de cáncer de colon (en población de 50 a 70 años), Exámenes auxiliares para el cuidado prenatal continuo.

- **Recuperación de la Salud**

  - **Diagnóstico:** Atención para confirmación de diagnóstico de hipertensión arterial y estratificación de riesgo cardiovascular, Atención médica especializada a personas con sospecha de cáncer de colon, Atención de urgencias y emergencias a la mujer víctima de violencia.

  - **Tratamiento:** Tratamiento farmacológico, Tratamiento de radioterapia/quimioterapia, Manejo del paciente con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, Cirugía de reemplazo de cadera, Trasplante renal, tratamiento con yodo radioactivo para hipertiroidismo, administración de sales de hierro vía oral para anemia por deficiencia de hierro, atención nutricional.

  - **Cuidados Paliativos:** Manejo del dolor asociado al tratamiento de radioterapia/quimioterapia, Manejo del dolor por la infiltración del tumor en otros órganos, Control del dolor crónico por neuropatía diabética, Soporte y orientación para el adecuado afrontamiento de la enfermedad y cuidados de fin de vida.

- **Rehabilitación de la salud:** Rehabilitación por enfermedad articular degenerativa, Rehabilitación por trastorno del lenguaje expresivo verbal, Rehabilitación cardiaca post Infarto agudo de miocardio, Rehabilitación pulmonar post neumonía COVID-19, Entrenamiento para la orientación, movilidad, y uso del bastón en pacientes con discapacidad visual, Fortalecimiento del rendimiento funcional.

C. ALVARADO CH.

Las intervenciones de salud se redactan considerando lo siguiente:

- Usar forma nominal (sin verbos conjugados en presente, pasado o futuro)
- Iniciar con un sustantivo de acción (verbo sustantivado) que indique el tipo de prestación o intervención de salud (ejemplo: atención, consejería, seguimiento, fortalecimiento, control, evaluación, tratamiento, inmunización, etc.)
- Describir de manera clara y breve la población o el tema de la intervención de salud, según corresponda.
- Si corresponde, añadir la finalidad, condición o contexto (ejemplo: "para monitoreo..." "en alojamiento conjunto...", en la comunidad rural...").

Ejemplos:
- Consejería para el cuidado de la salud del recién nacido
- Inmunización según esquema normado
- Atención nutricional para el cuidado prenatal.
- Seguimiento clínico periódico para monitoreo de control metabólico y compromiso de órgano blanco
- Atención médica especializada a personas con sospecha de cáncer de colon
- Atención psicoemocional del paciente diabético con complicaciones
- Consejería/Orientación de prevención de violencia basada en género

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.

2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 1 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.



Ejemplo del registro de la Herramienta 1: identificación de intervenciones de salud individual

Herramienta 1: Identificación de intervenciones de salud individual							
VCIS	**CÁNCER DE CUELLO UTERINO**						
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Tipo de oferta de servicios de salud**			**Tipo de soporte**		
		Fija	**Móvil**	**Telesalud**	**Documento Normativo**	**Evidencia científica**	**Experiencia**
Promoción de la salud	Consejería preventiva sobre factores de riesgo para el cáncer	X	X	X	X		
	Intervención de salud "n"	*X*	*X*	*X*		*X*	
Prevención de la enfermedad	Vacunación contra el VPH	X	X		X	X	
	Intervención de salud "n"	*X*			*X*		
Diagnóstico	Biopsia con/sin colposcopia	X			X	X	
	Intervención de salud "n"	*X*				X	
Tratamiento	Tratamiento de quimioterapia	X				X	
	Intervención de salud "n"	*X*			X		
Rehabilitación de la salud	Tratamiento fisioterapéutico de secuelas	X				X	
	Intervención de salud "n"	*X*			X		
Cuidados Paliativos	Atención en cuidado paliativos: Manejo del dolor	X	X		X		
	Intervención de salud "n"	*X*	*X*				X

C. ALVARADO CH.

Ejemplo referencial

ANEXO 6

Herramienta 2: Identificación de intervenciones de salud pública

Herramienta 2: Identificación de intervenciones de salud pública											
VCIS											
Intervención de salud pública	Se relaciona con								Tipo de soporte		
	FUNCION ESENCIAL DE SALUD PUBLICA							Gestión de los Determinantes Sociales de la Salud			
	1	2	5	7	9	10	11				
	Monitoreo y evaluación de la salud y el bienestar, la equidad, los determinantes sociales de la salud y el desempeño e impacto de los sistemas de salud	La vigilancia en la salud pública, el control y la gestión de los riesgos para la salud y las emergencias.	Participación y movilización social, inclusión de actores estratégicos y transparencia.	Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales de calidad, seguras y eficaces	Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad.	Acceso equitativo a intervenciones que buscan promover la salud, reducir factores de riesgo y favorecer comportamientos saludables	Gestión y promoción de las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud		Evidencia científica	Documento Normativo	Experiencia

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 2: Identificación de intervenciones de salud pública

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de identificación de las intervenciones de salud pública de la VCIS que se elabora.

El equipo elaborador en sesión y con previo conocimiento del objetivo de la actividad, en base a la evidencia científica, el marco normativo vigente y/o a su experiencia, considerando las Guías de Práctica Clínica, Documentos Normativos vigentes, el Plan Esencial de Aseguramiento, documentos relacionados al presupuesto por resultados, entre otros, identifica y plantea, previo acuerdo, las intervenciones de salud pública para la VCIS que se elabora, considerando el alcance de la VCIS, la integralidad y continuidad del cuidado integral de la salud.

El equipo elaborador clasifica las intervenciones de salud pública identificadas, teniendo en cuenta si se relaciona con la Función Esencial de Salud Pública (FESP), con la gestión de los determinantes sociales de la salud, el tipo de oferta de servicios de salud y el tipo de soporte (Evidencia científica, Documento Normativo y/o experiencia de los integrantes del equipo elaborador). Para ello marca con un aspa (X) según corresponda.

Las intervenciones de salud pública están comprendidas por las prestaciones de salud pública y por acciones de los actores sociales (*) para la gestión de los determinantes sociales de la salud.
(*) Actor social: Es aquel individuo o colectivo con intereses, condiciones y características particulares que lo identifica como tal, capaz de construir y llevar a cabo en forma individual o conjunta, un proyecto de transformación social para la salud, bienestar y desarrollo de la persona, familia y comunidad del territorio de la RIS.

Un actor social individual es un Agente Comunitario de Salud, un promotor de salud, una partera, un líder comunitario, entre otros, que actúan en el territorio de la RIS. Un actor social colectivo es la asociación de vaso de leche, comité de madres de familias, comité local comunal, asociación de diabéticos, Junta de Usuarios de los Servicios de Salud, representantes de sectores del Poder Ejecutivo, representantes de los Gobiernos Regionales, alcaldes provinciales y distritales, Gestores de la Red Integrada de Salud, entre otros, que actúan en el territorio de la RIS.

C. ALVARADO CH.

- **Prestación de Salud**
  Es la unidad básica de la cartera de servicios de salud del Establecimiento de Salud y Servicio Médico de Apoyo, que de manera general engloba los procedimientos médicos y sanitarios que se brindan a los usuarios de salud. De acuerdo al objeto a quien se brinda comprende, prestación de salud individual y prestación de salud pública; y de acuerdo a la naturaleza de lo que se brinda comprende, prestación de salud final o prestación de salud intermedia.

  A continuación, se presenta un listado referencial con prestaciones de salud pública:

UPSS/Sub UPSS	Prestación de Salud	FESP	
Sub UPSS Atención en Salud Pública	a. Identificación de necesidades de salud de la población con participación de la comunidad. b. Manejo de información de la población por riesgos y daños a la salud.	FESP 1	Monitoreo y evaluación de la salud y el bienestar, la equidad, los determinantes sociales de la salud y el desempeño e impacto de los sistemas de salud.
	a. Vigilancia epidemiológica por personal de la salud. b. Investigación epidemiológica de brotes, epidemias y eventos de importancia en salud pública.	FESP 2	La vigilancia en la salud pública, el control y la gestión de los riesgos para

UPSS/Sub UPSS	Prestación de Salud	FESP	
	c. Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano d. Vigilancia y control de vectores e. Vigilancia y control de reservorios f. Vigilancia de la calidad sanitaria de playas g. Vigilancia de la calidad sanitaria de piscinas h. Vigilancia sanitaria de sustancias químicas i. Vigilancia sanitaria de suelo superficial de uso residencial y parques j. Vigilancia sanitaria de la calidad del aire k. Inspección sanitaria por humo de tabaco l. Vigilancia de la inocuidad de los alimentos por personal de la salud m. Gestión y manejo de residuos sólidos por personal de la salud n. Vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud por personal de la salud		la salud y las emergencias.
	a. Coordinación para la vigilancia ciudadana en salud	FESP 5	Participación y movilización social, inclusión de actores estratégicos y transparencia.
	a. Promoción del uso racional de medicamentos y manejo de productos farmacéuticos y sanitarios.	FESP 7	Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales de calidad, seguras y eficaces
	a. Promoción del uso de tecnologías para la atención de salud. b. Consejería grupal a cuidadores.	FESP 9	Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad.
	a. Coordinación intersectorial con municipalidades, comités de salud y organizaciones sociales para desarrollar acciones con actores y autoridades del ámbito.	FESP 10	Acceso equitativo a intervenciones que buscan promover la salud, reducir factores de riesgo y favorecer comportamientos saludables.
	a. Coordinación a nivel intersectorial para promover acciones de cuidado integral.	FESP 11	Gestión y promoción de las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud.
UPSS Laboratorio de Salud Pública	a. Procedimientos de laboratorio de salud pública b. Teleprocedimientos de laboratorio de salud pública	FESP 2	Vigilancia de la salud pública, control y gestión de los riesgos y emergencias para la salud.

C. ALVARADO CH.

A continuación, se presenta un listado referencial con acciones de los actores sociales para la gestión de los Determinantes Sociales de la Salud:

a) Intervención sobre condición de vivienda
b) Intervención sobre condición de abastecimiento de agua dentro de la vivienda
c) Intervención sobre la condición del sistema de alcantarillado sanitario dentro de la vivienda
d) Intervención sobre la condición de acceso al servicio de recojo de residuos sólidos y limpieza pública
e) Intervención sobre las condiciones del nivel educativo de la población
f) Intervención sobre las condiciones de ocupación de la población (empleo, ocupación, trabajo)
g) Promover la disponibilidad de infraestructuras, bienes y servicios que incentiven el transporte activo (aceras, ciclovías, parqueaderos para bicicletas, adecuado uso del suelo, planeación urbana, etc.)
h) Promover regulación respecto a etiquetado de advertencia en los alimentos procesados (octógonos)
i) Promover ambientes 100% libres de humo
j) Promover oferta de alimentos saludables y educación nutricional en el lugar de trabajo (Puntos de distribución de frutas y verduras)

Las intervenciones de salud pública sean relacionadas a las FESP o a la gestión de los determinantes sociales de la salud, al igual que las intervenciones de salud individual, son insumos para los siguientes pasos de elaboración de la VCIS.



En lo que respecta al tipo de soporte de las intervenciones de salud pública, se dispone de tres alternativas, no excluyentes:

- **Evidencia científica:** Intervenciones de salud identificadas en información científica obtenida de fuentes confiables y sometida a evaluación crítica. Se considera: Guías de Práctica Clínica, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohortes, estudios de casos y controles, y series o reporte de casos, entre otros. Se excluye lo correspondiente a la experiencia profesional personal.

- **Documento Normativo:** Intervenciones de salud identificadas en documentos normativos aprobados por el Ministerio de Salud que son de obligatorio o referencial cumplimiento. Se considera Normas Técnicas de Salud (NTS), Documentos Técnicos, Guías Técnicas y Directivas Sanitarias vigentes.

- **Experiencia**: Intervenciones de salud identificadas a partir del conocimiento adquirido a través de la práctica profesional en contextos reales, sustentados principalmente en la observación clínica y en el juicio individual. Se considera: opinión de expertos, anécdotas clínicas o casos aislados.

Las intervenciones de salud se redactan considerando lo siguiente:

- Usar forma nominal (sin verbos conjugados en presente, pasado o futuro)
- Iniciar con un sustantivo de acción (verbo sustantivado) que indique el tipo de intervención de salud (ejemplo: atención, consejería, seguimiento, fortalecimiento, control, evaluación, tratamiento, inmunización, etc.)
- Describir de manera clara y breve la población o el tema de la intervención de salud, según corresponda.
- Si corresponde, añadir la finalidad, condición o contexto (ejemplo: "para monitoreo..." "en alojamiento conjunto...", en la comunidad rural...").

A continuación, se citan algunos ejemplos de Intervenciones de Salud Pública:

a) Promoción del uso del cinturón de seguridad
b) Fortificación del arroz con micronutrientes
c) Promoción de actividad física durante 30 minutos
d) Implementación del impuesto al tabaco
e) Acceso a agua segura
f) Respuesta oportuna a brotes, epidemias y eventos de importancia en salud pública
g) Articulación y coordinación para el diseño de políticas en temas priorizados
h) Provisión de agua potable y disposición de excretas
i) Fortalecimiento de capacidades de actores sociales del SNS para la vigilancia en salud pública
j) Fomento de la participación ciudadana en salud
k) Respuesta oportuna ante desastres naturales
l) Fomento de la actividad física organizada y dirigida a la población por momentos de curso de vida

La intervención de salud pública es diferente al medio que requieren para lograr la acción concreta que llega a toda la población.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 2 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

C. ALVARADO CH.

Ejemplo del registro de la Herramienta 2: Identificación de intervenciones de salud pública

Herramienta 2: Identificación de intervenciones de salud pública											
VCIS	HIPERTENSIÓN ARTERIAL										
Intervención de salud pública	**Se relaciona con**								**Tipo de soporte**		
	FUNCION ESENCIAL DE SALUD PUBLICA							**Gestión de los Determinantes Sociales de la Salud**			
	1	**2**	**5**	**7**	**9**	**10**	**11**				
	Monitoreo y evaluación de la salud y el bienestar, la equidad, los determinantes sociales de la salud y el desempeño e impacto de los sistemas de salud	**La vigilancia en la salud pública, el control y la gestión de los riesgos para la salud y las emergencias.**	**Participación y movilización social, inclusión de actores estratégicos y transparencia.**	**Asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales de calidad, seguras y eficaces**	**Acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad.**	**Acceso equitativo a intervenciones que buscan promover la salud, reducir factores de riesgo y favorecer comportamientos saludables**	**Gestión y promoción de las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud**		**Evidencia científica**	**Documento Normativo**	**Experiencia**
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la hipertensión arterial y sus complicaciones		X						X	X	X	
Fomento del cumplimiento de la regulación peruana antitabaco, nicotina y sucedáneos.	X	X						X		X	
Intervención de salud pública "n"			X								X

Ejemplo referencial

ANEXO 7

Herramienta 3: Descripción de intervenciones de salud

Herramienta 3A: Descripción de Intervenciones de salud individual																												
VCIS																												
Intervención de salud	Intervención de salud individual	Código CPMS	Quién																	Dónde					Cómo				
			Médico cirujano	Médico especialista (especificar especialidad y/o subespecialidad)	Enfermera/o	Enfermera/o especialista (especificar especialidad)	Obstetra	Obstetra especialista (especificar especialidad)	Técnico o auxiliar asistencial en salud (*)	Técnico o auxiliar asistencial en salud capacitado (especificar capacitación) (*)	Cirujano Dentista	Cirujano Dentista especialista (especificar especialidad)	Licenciada/o en nutrición	Licenciada/o en nutrición especialista (especificar especialidad)	Licenciada/o en psicología	Licenciada/o en psicología especialista (especificar especialidad)	Otros profesionales de la salud (especificar)	Otros profesionales especialistas (especificar especialidad y/o subespecialidad)	Establecimiento de Salud	Hogar	Instituciones Educativas	Centro Laboral	Comunidad	Descripción de la intervención de salud	Población objetivo	Tecnología en salud (trazadora)	Frecuencia de uso	Dosificación
Promoción de la salud																												
Prevención de la enfermedad																												
Diagnóstico																												
Tratamiento																												
Rehabilitación de la salud																												
Cuidados paliativos																												

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Herramienta 3B: Descripción de Intervenciones de Salud Pública																		
VCIS																		
Intervención de Salud Pública	Quién									Dónde					Cómo			
	Sectores del Poder Ejecutivo (especificar)	Gobiernos Regionales	Alcaldes provinciales	Alcaldes distritales	Gestores de la RIS	Organizaciones Sociales (especificar)	Actores sociales individuales (especificar)	RHUS	Otros (especificar)	E.S.	Hogar	Institución Educativa	Centro laboral	Comunidad	Descripción de la intervención de salud	Población objetivo	Tecnología para emplearse (trazadora)	Otras especificaciones

C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 3A y 3B: Descripción de intervenciones de salud

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de caracterización y descripción de las intervenciones de salud identificadas para la VCIS que se elabora.

El equipo elaborador en sesión y con previo conocimiento del objetivo de la actividad, describen cada intervención de salud individual y de salud pública identificadas previamente, usando las herramientas 3A y 3B respectivamente.

Para la caracterización de cada intervención de salud, se considera las orientaciones siguientes:

Para las intervenciones de salud individual

- **Intervención de salud individual:** Consigne la intervención de salud individual identificada previamente.
- **Código CPMS:** Ingrese el o los códigos del Listado de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud que hacen parte de la intervención de salud, según corresponda.
- **Quién:** Marque con un aspa (X) en la celda correspondiente a los RHUS que brindan las intervenciones de salud identificadas sea médico cirujano, médico especialista, obstetra, enfermera/o entre otros profesionales de la salud, consignando la especialidad o subespecialidad según corresponda, no siendo excluyentes necesariamente. Asimismo, de corresponder, para el caso de los técnicos o auxiliares asistenciales en salud, especificar si participa en apoyo a un profesional de salud precisándolo en la celda respectiva.
- **Dónde:** Marque con un aspa (X) en la celda correspondiente al escenario de cuidado en donde se desarrolla la intervención de salud: Hogar, Instituciones Educativas, Centro Laboral, Establecimiento de Salud, Comunidad, entre otros.
- **Cómo:** Describa de manera concreta la intervención de salud, indicando su propósito y componentes principales, así como la población objetivo de la intervención de salud, la tecnología en salud (considerando la tecnología trazadora), la frecuencia de uso, la dosificación cuando corresponda. En los casos en que no aplique alguno de estos campos, consigne "No aplica", a excepción del campo "descripción de la intervención de salud", este se registra de manera obligatoria.

Para las intervenciones de salud pública

- **Intervención de salud pública:** Consigne la intervención de salud pública identificada previamente.
- **Quién:** Especifique en la celda según corresponda a: representantes de los sectores del Poder Ejecutivo, representantes del Gobierno Regional, Gobiernos municipales, Gestores de la RIS, organizaciones sociales, actores sociales individuales, RHUS, entre otros, no siendo excluyentes necesariamente.
- **Dónde**: Marque con un aspa (X) en la celda correspondiente al escenario de cuidado en donde se desarrolla la intervención de salud: Hogar, Instituciones Educativas, Centro Laboral, Establecimiento de Salud, Comunidad, entre otros.
- **Cómo:** Describa de manera concreta la intervención de salud pública, incorporando su propósito y componentes principales, así como la población objetivo de la intervención de salud, la tecnología en salud (incluyendo la tecnología trazadora) y otras especificaciones que correspondan. En los casos en que no aplique alguno de estos campos, consigne "No aplica".

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 3 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.



Ejemplo del registro de la Herramienta 3A y 3B: Descripción de intervenciones de salud

Herramienta 3A: Descripción de intervenciones de salud individual																			
VCIS	**DIABETES MELLITUS TIPO 2**																		
			Quién							**Dónde**					**Cómo**				
Intervención de salud	Intervención de salud individual	Código CPMS	Médico cirujano	Médico especialista	Enfermera/o	Técnico o auxiliar	Licenciada/o en	Licenciada/o en psicología	Otros profesionales de la salud	Establecimiento de Salud	Hogar	Instituciones Educativas	Centro Laboral	Comunidad	Descripción de la intervención de salud	Población objetivo	Tecnología en salud (trazadora)	Frecuencia de uso	Dosificación
Promoción de la salud	Consejería en la importancia del autocuidado y los estilos de vida saludable.	99401.13 99402.17	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	Esta intervención de salud busca orientar, informar y educar a las personas con factores de riesgo asociados a la diabetes para que desarrollen capacidades para el cuidado de la salud en los siguientes factores protectores: ▪ Actividad física regular. ▪ Alimentación saludable ▪ Educación e información acerca de los hábitos nocivos del consumo de alcohol y el hábito de fumar. ▪ Manejo de estrés. ▪ Higiene del sueño. Los temas abordar durante la consejería serán priorizados a criterio del profesional a cargo.	Joven sano, adulto sano, adulto mayor sano.	No aplica	Anual	No aplica

C. ALVARADO CH.

Prevención de la enfermedad	Consejería en la cesación del consumo de tabaco, sucedáneos y consumo nocivo de alcohol	99401.23	X		X		X	X		X	X	X	X	X	La consejería para cesación de tabaco incluye los siguientes temas: ▪ Consejería individual y/o grupal para prevención del inicio del consumo de tabaco. ▪ Orientación para la identificación temprana del consumo experimental, habitual o dependiente. ▪ Intervención breve de cesación tabáquica basada en modelo de las 5A (Abordar, Aconsejar, Analizar, Asistir, Acordar seguimiento). ▪ Derivación a servicios especializados en casos de dependencia moderada o severa.	Joven sano, adulto sano, adulto mayor sano, persona con sobrepeso según el curso de vida	▪ Cinco 5As ▪ Herramientas validadas de acuerdo a guías de manejo.	Anual	No aplica
Diagnóstico	Confirmación diagnóstica para diabetes mellitus 2 con exámenes auxiliares	82947 82951 83036	X	X (Medicina Interna, Medicina Endocrinología, familiar)						X					Se solicita análisis de laboratorio clínico para realizar la confirmación diagnóstica de diabetes mellitus 2 en los pacientes. Estos incluyen: ▪ Glicemia en ayunas ▪ Glucosa en plasma 2 horas después de una carga oral. ▪ Hemoglobina glicosilada (según GPC). ▪ Glucosa al azar (mayor de 200mg/dl) en personas con síntomas clásicos de diabetes mellitus 2.	Persona con sospecha de diabetes.	▪ Glicemia, ▪ Hemoglobina glicosilada	Única	No aplica
Tratamiento	Tratamiento farmacológico y no farmacológico según protocolos estandarizados.	99402.17 99403.01	X	X (Medicina Interna, Medicina Endocrinología, familiar)						X					<u>Tratamiento farmacológico:</u> ▪ Definir medicamento de primera línea según disponibilidad y guías de práctica clínica o documentos normativos vigentes. ▪ Inicio de estatinas y antihipertensivos de acuerdo a protocolos estandarizados de manejo. <u>Tratamiento no farmacológico:</u> ▪ Educación en la nutrición. ▪ Actividad física.	Persona con diagnóstico de Diabetes mellitus 2.	▪ Medicamento antidiabético oral ▪ Estatinas ▪ Antihipertensivos.	Única	Según protocolos estandarizados de manejo.

C. ALVARADO CH.

Rehabilitación de la salud	Fortalecimiento del rendimiento funcional.	97530		X (Medicina física)				X	TM en Rehabilitación física	X				Valoración por terapia física y/o medicina de rehabilitación en pacientes en los cuales se vea afectada la funcionalidad y su rendimiento.	Paciente adulto, adulto mayor con diagnóstico de diabetes mellitus 2, en los que se identifica alteración del estado funcional.	Escalas para medir la funcionalidad, según disponibilidad	De acuerdo al nivel de afectación funcional.	Según guía de manejo.
Cuidados paliativos	Atención psicoemocional del paciente diabético con complicaciones.	96100 96100.01		X (Psiquiatra)				X	Profesionales de la salud capacitados	X	X				Valoración por profesional de salud capacitado en salud mental para identificar y abordar los factores emocionales, psicológicos y sociales que influyen en el control y evolución de la diabetes mellitus 2 con complicaciones, en busca de mejorar el bienestar emocional del paciente, fortalecer su motivación y habilidades de autocuidado y una mejora sostenida a la calidad de vida.	Paciente adulto, adulto mayor con diagnóstico de diabetes mellitus 2 con complicación	Herramientas validadas de acuerdo a guías de manejo.	De acuerdo a Documento Normativo Vigente	Según guía de manejo.

Ejemplo referencial

C. ALVARADO C.

Ejemplo Herramienta 3B: Descripción de Intervenciones de Salud Pública

VCIS	DIABETES MELLITUS TIPO 2																
	Quién							Dónde					Cómo				
Intervención de Salud Pública	Sectores del Poder Ejecutivo (especificar)	Gobierno Regional	Alcaldía distrital	Alcaldía Provincial	Gestores de la RIS	Actores sociales individuales	RHUS	E.S.	Hogar	Institución Educativa	Centro laboral	Comunidad	Descripción de la intervención de salud	población objetivo	tecnología para emplearse (trazadora)	otras especificaciones
Promoción de estilos de vida saludable y del autocuidado.	MINEDU (docentes capacitados), MINSA	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Jefe de equipo Gestión Social e Intersectorial y DSS	Agente comunitario, voluntarios en la comunidad	Profesionales asistenciales y profesionales técnicos del primer nivel de atención capacitados.	X	X	X	X	X	▪ Promover la adopción de estilos de vida saludables y del autocuidado, mediante sesiones educativas y demostrativas que fomenten en la población la toma de decisiones informadas, el autocuidado, los estilos de vida saludables y la protección de las personas y su entorno. ▪ Promover sesiones educativas y demostrativas en estilos de vida saludable: alimentación saludable, actividad física, gestión del estrés, sueño adecuado. ▪ Promover la articulación intersectorial y de diferentes niveles de gobierno que fomenten los estilos de vida saludable y las prácticas de autocuidado. ▪ Promover la corresponsabilidad social y el bienestar colectivo. ▪ Implementar estrategias multisectoriales para generar entornos saludables.	Todos los cursos de vida	Herramienta de evaluación y registro del programa de Agentes Comunitarios de Salud (ACS).	No aplica

C. ALVARADO CH.

Tamizaje poblacional de riesgo metabólico (herramienta FINDRISC).	MINSA	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Jefe de equipo Gestión Social e Intersectorial y DSS	Agente comunitario capacitado	Profesionales asistenciales y profesionales técnicos del primer nivel de atención capacitados	X	X	X	X	X	El tamizaje poblacional incluye: ▪ Fortalecimiento de la búsqueda activa de personas en riesgo de diabetes mellitus 2 a través de acciones comunitarias y en establecimientos de salud. ▪ Implementar herramientas (FINDRISC u otras definidas), con el propósito de identificar personas en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y facilitar intervenciones preventivas	Joven Adulto Adulto Mayor	Herramienta FINDRISC	No aplica
Fomento de programas de cesación del consumo de alcohol.	MINSA	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Jefe de equipo Gestión Social e Intersectorial y DSS		Profesionales asistenciales y profesionales técnicos del primer nivel de atención capacitados.	X	X	X	X	X	La estrategia intersectorial y diferentes niveles de gobierno para la prevención del consumo de alcohol incluye: ▪ Educar, informar a través de campañas la reducción del consumo de alcohol. ▪ Incidir en la vigilancia y control de la publicidad, etiquetado y comercialización de bebidas alcohólicas. ▪ Promoción de espacios saludables libres de alcohol. ▪ Desarrollar acciones comunitarias y en establecimientos de salud para identificar a personas con consumo y dependencia a las bebidas alcohólicas y ofrecer intervenciones integrales de consejería, farmacoterapia, psicoterapia y acompañamiento para apoyar la cesación de consumo de alcohol.	Adolescente Joven Adulto	No aplica	No aplica
Fomento de la actividad física según curso de vida.	MINEDU, MVCS, MTC, MTPE	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre [illegible]	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre otros)	Gerencia de Desarrollo Social (salud, educación, entre [illegible]	Jefe de equipo Gestión Social e Intersectorial y DSS		Profesionales asistenciales y profesionales técnicos del primer nivel de atención capacitados.	X	X	X	X	X	▪ Fomentar y promover el acceso oportuno, inclusivo y sostenible a espacios deportivos, recreativos y artísticos. ▪ Promover la participación familiar ▪ A través de la articulación intersectorial y de diferentes niveles de gobierno para realizar campañas comunicacionales y educativas, acciones comunitarias que contribuyan a mejorar las condiciones que favorecen la actividad física.	Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Adultos Mayores	Cartilla educativa y guía metodológica del programa muévete Perú	No aplica

Ejemplo referencial

C. ALVARADO CH.

C. ALVARADO CH.

ANEXO 8

Herramienta 4: Preselección de intervenciones de salud

Herramienta 4: Preselección de intervenciones de salud											
VCIS											
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Criterios de Preselección**	**Integrante Equipo Elaborador 1**	**Integrante Equipo Elaborador 2**	**Integrante Equipo Elaborador 3**	**Integrante Equipo Elaborador 4**	**Integrante Equipo Elaborador 5**	**Integrante Equipo Elaborador "n"**	**Preseleccionada**	
									SI	**NO**
Promoción de la salud	Intervención de salud 1	Relevancia								
		Factibilidad								
Prevención de la enfermedad	Intervención de salud 2	Relevancia								
		Factibilidad								
Diagnóstico	Intervención de salud 3	Relevancia								
		Factibilidad								
Tratamiento	Intervención de salud 4	Relevancia								
		Factibilidad								
Rehabilitación de la salud	Intervención de salud 5	Relevancia								
		Factibilidad								
Cuidados paliativos	Intervención de salud "n"	Relevancia								
		Factibilidad								
Intervención de salud pública		**Criterios de Preselección**	**Integrante Equipo Elaborador 1**	**Integrante Equipo Elaborador 2**	**Integrante Equipo Elaborador 3**	**Integrante Equipo Elaborador 4**	**Integrante Equipo Elaborador 5**	**Integrante Equipo Elaborador "n"**	**Preseleccionada**	
									SI	**NO**
Intervención de salud pública 1		Relevancia								
		Factibilidad								
Intervención de salud pública 2		Relevancia								
		Factibilidad								
Intervención de salud publica n		Relevancia								
		Factibilidad								

Instructivo de la herramienta 4: Preselección de intervenciones de salud

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de preselección de intervenciones de salud para la VCIS. La herramienta está estructurada en base a dos criterios para la preselección: relevancia y factibilidad de la intervención de salud.

Cada integrante del equipo elaborador en sesión, con previo conocimiento del objetivo de la actividad y según el alcance de la VCIS, realiza una evaluación individual por cada intervención de salud identificada y descrita previamente, a partir de dos criterios:

- **Relevancia de la intervención de salud:** Importancia para la reducción de la carga de la enfermedad y/o reducción de la discapacidad relacionada a la condición de salud a ser abordada en la VCIS.

- **Factibilidad de la intervención de salud:** Posibilidad de que la intervención de salud sea implementada exitosamente ya sea por su pertinencia, factibilidad económica, disponibilidad de recursos y aceptabilidad.

Para cada intervención de salud identificada, cada integrante del equipo elaborador evalúa de manera dicotómica (SI o NO).

Seguidamente y considerando la evaluación individual de todos los integrantes del equipo elaborador, se determina por acuerdo técnico cuales intervenciones de salud son preseleccionadas y cuales se excluyen, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Se preseleccionan aquellas intervenciones de salud que cumplan con ambos criterios (SI en relevancia y factibilidad) por parte de todos los integrantes del equipo elaborador.
- Las intervenciones que hayan recibido al menos un NO en alguno de los criterios son consideradas con discrepancias y serán sometidas a deliberación grupal.

Para la deliberación se considera lo siguiente:

- Cada integrante justifica su evaluación aportando datos o argumentos.
- Se discuten las razones detrás de los "NO" y si estas pueden resolverse mediante ajustes o aclaraciones.
- Si, tras la deliberación, se logra acuerdo para "SI" en ambos criterios, la intervención de salud se preselecciona.
- Si no se logra acuerdo para "SI" en ambos criterios se considera lo siguiente:
  - Si más de la mitad de los integrantes vota "SI" en ambos criterios, la intervención de salud se preselecciona.
  - Si más de la mitad vota "NO" en alguno de los criterios, la intervención de salud se excluye.
  - En casos de empate exacto, la intervención de salud no se preselecciona, salvo que se logre un acuerdo mediante ajustes o aclaraciones discutidos durante la deliberación.

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

En el caso que la intervención de salud fuera preseleccionada se incluye en el siguiente paso.

En el caso que la intervención de salud NO fuera preseleccionada se excluye y se dejará evidencia del análisis en el acta de la sesión. En caso de votos divididos, se incluyen las razones principales de los "SÍ" y "NO" para documentar el análisis realizado.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.

3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 4 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

Al finalizar la preselección de las intervenciones de salud, el equipo elaborador revisa y ajusta la redacción de cada intervención de salud preseleccionada, de corresponder.



Ejemplo del registro de la herramienta 4: Preselección de intervenciones de salud

Ejemplo de registro herramienta 4: Preselección de intervenciones de salud											
VCIS		CÁNCER DE CUELLO UTERINO									
Intervención de salud	Intervención de salud individual	Criterios de Preselección	Integrante Equipo Elaborador 1	Integrante Equipo Elaborador 2	Integrante Equipo Elaborador 3	Integrante Equipo Elaborador 4	Integrante Equipo Elaborador 5	Integrante Equipo Elaborador "n"	Preseleccionada	
									SI	NO
Promoción de la salud	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
	Intervención de salud "n"	Relevancia	No	No	No	No	No	No		X
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Prevención de la enfermedad	Vacunación contra el VPH	Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
	Intervención de salud "n"	Relevancia	No	Si	Si	Si	No	No		X
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	No		
Diagnóstico	Biopsia con/sin colposcopia	Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	No		
	Intervención de salud "n"	Relevancia	No	No	No	Si	No	No		X
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	No		
Tratamiento	Quimioterapia	Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
	Intervención de salud "n"	Relevancia	Si	No	No	Si	No	No		X
		Factibilidad	Si	No	Si	Si	Si	No		
Rehabilitación de la salud	Tratamiento fisioterapéutico de secuelas	Relevancia	No	Si	Si	Si	Si	No	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	No		
		Relevancia	Si	No	No	Si	No	No		X

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

	Intervención de salud "n"	Factibilidad	Si	No	Si	Si	Si	No		
Cuidados paliativos	Atención cuidado paliativos: Manejo del dolor	Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	No		
	Intervención de salud "n"	Relevancia	Si	Si	No	Si	Si	No	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	No		
Intervención de salud pública		**Criterios de Preselección**	**Integrante Equipo Elaborador 1**	**Integrante Equipo Elaborador 2**	**Integrante Equipo Elaborador 3**	**Integrante Equipo Elaborador 4**	**Integrante Equipo Elaborador 5**	**Integrante Equipo Elaborador "n"**	**Preseleccionada**	
									SI	**NO**
Identificación de necesidades de salud de la población con participación de la comunidad		Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	No	Si	Si	Si	Si	Si		
Promover ambientes 100% libres de humo		Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Promoción de actividad física durante 30 minutos		Relevancia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Inspección sanitaria por humo de tabaco		Relevancia	Si	Si	Si	Si	No	No	X	
		Factibilidad	Si	Si	Si	Si	No	No		
Intervención de salud pública "n"		Relevancia	No	Si	Si	Si	Si	Si		X

C. ALVARADO CH.

Ejemplo referencial

ANEXO 9

Herramienta 5: Selección de Guías de Práctica Clínica

Herramienta 5: Selección de Guías de Práctica Clínica						
VCIS						
Criterio de selección	**GPC 1**	**GPC 2**	**GPC 3**	**GPC 4**	**GPC 5**	**GPC "n"**
1. ¿El año de publicación es menor a los 5 años?						
2. ¿Coincide con el alcance de la VCIS a desarrollar? (En caso de coincidencia parcial especificar que aspectos cubre: Diagnóstico, tratamiento, prevención, otros)						
3. ¿Se describe el proceso de desarrollo de la guía?						
4. ¿Brinda información sobre la conformación del grupo elaborador?						
5. ¿Aborda preguntas claras? (se pueden identificar los componentes PICO)						
6. ¿Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura para cada una de las preguntas? (múltiples bases de datos, se incluyen todos los términos claves)						
7. ¿Es replicable la búsqueda de evidencia? (Las estrategias de búsqueda están disponibles)						
8. ¿Se emiten recomendaciones y es posible identificar la evidencia que las respalda? (Cada recomendación está enlazada a una descripción de la evidencia y/o tabla de evidencia)						
9. ¿Utilizó la metodología GRADE para valorar la certeza de la evidencia y las tablas de evidencia están disponibles? (¿Perfil de evidencia o Resumen de hallazgos? (ideal)						
10. ¿Utilizó la metodología GRADE para formular las recomendaciones? (el marco de la Evidencia a la Decisión (EtD) está disponible (tablas o narrativo)? (ideal)						
Elegible para evaluación mediante AGREE II						

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 5: Selección de Guías de Práctica Clínica

Este instructivo establece el proceso para la búsqueda, evaluación y selección de Guías de Práctica Clínica (GPC) que serán el soporte de las intervenciones de salud preseleccionadas.

El equipo elaborador como primer insumo para el soporte de las intervenciones de salud preseleccionadas realiza la búsqueda de evidencia científica en los siguientes documentos, en orden de prioridad:

- Guías de práctica clínica aprobadas por el Ministerio de Salud y Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud.
- Guías de práctica clínica aprobadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud.
- Guías u otras directrices informadas por evidencias de la Organización Mundial de la Salud.
- Guías de práctica clínica internacionales.

Para la búsqueda el equipo elaborador puede tomar como referencia los siguientes enlaces:

Fuentes para la búsqueda	Link
GPC MINSA	https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=normas&contenido%5B%5D=publicaciones&institucion%5B%5D=minsa&sort_by=recent
GPC IETSI	https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guias-de-practica-clinica/
Guías OMS	https://www.who.int/publications/i?publishingoffices=c09761c0-ab8e-4cfa-9744-99509c4d306b
GPC Internacionales	• National Guideline Clearinghouse (NGC) http://www.guideline.gov • Guidelines International Network (GIN): http://www.g-i-n.net/gin • New Zealand Guidelines Group (NZGG): http://www.health.govt.nz/ • Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk/index.html • Ministerio de Salud y Protección Social - IETS http://www.iets.org.co/ • Guía Salud: http://portal.guiasalud.es/web/guest/home • Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) http://www.cenetec.salud.gob.mx/ • CMA Infobase de la Canadian Medical Association: https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx • NICE Clinical Guidelines de la National Institute for Health and Clinical Evidence, UK: http://www.nice.org.uk/guidance • Evidence-Based Guidelines (Programs in Evidence-Based Care) de la Cancer Care Ontario: https://www.cancercare.on.ca/cms/One.aspx?portalId=1377&pageId=10144 • Best Practice Guidelines de la Registered Nurses Association of Ontario (RNAO): http://rnao.ca/bpg/guidelines?items=75 • Plataforma **TRIP:** http://www.tripdatabase.com

C. ALVARADO CH.